

Anatomo-pathologie 2

I. EPREUVES

JUILLET 2025 (NORMALE)

Q1. Cancer du sein

Une patiente de 52 ans consulte pour une masse palpable dans le quadrant supéro-externe du sein gauche. L'examen clinique révèle une masse indurée, irrégulière, fixée et non douloureuse. Il n'y a pas d'adénopathie axillaire palpable. La mammographie montre une opacité spiculée avec microcalcifications groupées. Quelle est la prochaine étape la plus appropriée pour le diagnostic ?

- A) Réaliser une échographie mammaire seule.
- B) Prescrire une IRM mammaire pour évaluer l'étendue.
- C) Effectuer une biopsie chirurgicale de la masse.
- D) Réaliser une microbiopsie (biopsie à l'aiguille guidée par imagerie) de la masse.
- E) Effectuer une cytoponction de la masse.

Q2. Cancer du sein

Quelle est la forme la plus fréquente de cancer du sein invasif ?

- A) Carcinome lobulaire invasif.
- B) Carcinome canalaire invasif ou mammaire infiltrant NOS.
- C) Carcinome mucineux.
- D) Carcinome médullaire.
- E) Maladie de Paget mammaire.

Q3. Cancer du sein

Le résultat histologique de cette patiente confirme un carcinome canalaire infiltrant. Quel sont les tests obligatoires anapath à compléter chez cette patiente ?

- A) Réaliser la recherche de récepteurs hormonaux.
- B) Rechercher le statut HER2.
- C) Rechercher le taux du ki67.
- D) Rechercher la densité vasculaire.
- E) Déterminer le degré d'invasion.

Q4. Cancer du sein

Le bilan d'extension ne révèle pas de métastases à distance. Les récepteurs hormonaux sont négatifs (RH-) et HER2 est positif (HER2+). La tumeur mesure 2,5 cm. Comment classer vous cette tumeur ?

- A) Luminal A.
- B) Luminal B.
- C) Her 2 enrichie.
- D) Triple négatif.
- E) Aucune des propositions.

Q5. Cancer du sein

Comment on peut rechercher l'expression de HER2 ?

- A) Coloration HE (hemalun éosine).
- B) Immunohistochimie.
- C) Hybridation in situ (FISH).
- D) Polarisation.
- E) Microscopie électronique.

Q6. Cancer du col de l'utérus

Parmi ces propositions, quelles sont les indications du FCU ?

- A) Dépistage du cancer du col.
- B) Suivi d'une femme ménopausée.
- C) Diagnostic d'une endométriose.
- D) Bilan de saignements post-ménopausiques.
- E) Détection d'une infection à Chlamydia.

Q7. Cancer du col de l'utérus

Quels éléments font partie de la classification de Bethesda pour les FCU anormaux ?

- A) ASC-US (Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance).
- B) LSIL (Low-Grade Squamous Intraepithelial Lesion).
- C) HSIL (High-Grade Squamous Intraepithelial Lesion).
- D) Adénome.
- E) Kyste de Naboth.

Q8. Cancer du col de l'utérus

Que préconise le programme national du dépistage du cancer du col au Maroc ?

- A) Un FCU.
- B) Un typage HPV.
- C) Un examen IVA (inspection visuelle à l'acide acétique).
- D) Une colposcopie si IVA positive.
- E) Une conisation si FCU anormal.

Q9. Cancer du col de l'utérus

Pour le FCU :

- A) On peut réaliser le FCU conventionnel.
- B) On peut réaliser le FCU en monocouche ou en milieu liquide.
- C) Le FCU se fait après le toucher vaginal.
- D) Le FCU conventionnel permet la recherche d'HPV.
- E) Il peut être fait pendant les menstruations.

Q10. Cancer du col de l'utérus

Quels sont les deux types histologiques les plus fréquents du cancer du col de l'utérus ?

- A) Le carcinome épidermoïde.
- B) Le mélanome malin.
- C) Le lymphome à petites cellules.
- D) L'adénocarcinome.
- E) Le carcinome canalaire infiltrant.

Q11. Adénites

À propos de l'architecture histologique d'un ganglion lymphatique :

- A) Le sinus sous-capsulaire sépare la capsule du parenchyme ganglionnaire.
- B) Le cortex contient des follicules primaires et secondaires.
- C) Le centre germinatif est riche en lymphocytes T.
- D) L'aspect en ciel étoilé est lié à la présence de macrophages à corps tingibles.
- E) Le CD3 marque les lymphocytes T.

Q12. Adénites

Concernant l'hyperplasie folliculaire réactionnelle :

- A) Elle est irréversible.
- B) Les follicules sont nombreux, élargis, et variables en taille.
- C) La polarité du centre germinatif est conservée.
- D) Le Bcl-2 est exprimé au niveau du centre germinatif.
- E) Le réarrangement IGH est polyclonal.

Q13. Adénites

À propos de l'immunohistochimie dans les adénites :

- A) CD20 marque les lymphocytes B.
- B) CD3 marque les lymphocytes T.
- C) Bcl-6 est un marqueur du centre germinatif.
- D) L'expression de Bcl-2 dans le centre germinatif est physiologique.
- E) CD10 est un marqueur du centre germinatif.

Q14. Adénites

Parmi les causes d'hyperplasie folliculaire réactionnelle, on retrouve :

- A) Médicaments.
- B) Infection virale par EBV.
- C) Infection bactérienne.
- D) Mycobacterium tuberculosis.
- E) Polluants environnementaux.

Q15. Lymphomes a petites cellules

Concernant la lymphomagenèse du lymphome folliculaire :

- A) La translocation t(14;18) entraîne une surexpression de Bcl-2.
- B) La translocation IGH-BCL2 est suffisante à elle seule pour provoquer le lymphome.
- C) Bcl-2 est une protéine pro-apoptotique.
- D) Des cellules IGH-BCL2+ peuvent être retrouvées chez des sujets sains.
- E) Les cytokines IL-4 et IL-21 favorisent la survie des cellules lymphomateuses.

Q16. Lymphomes a petites cellules

Parmi les caractéristiques microscopiques du lymphome folliculaire, on retrouve :

- A) Polarité conservée des centres germinatifs.
- B) Follicules de formes et tailles similaires.
- C) Mitoses très fréquentes dans les follicules.
- D) Macrophages à corps tingibles absents ou rares.
- E) Envahissement possible de la graisse hilare.

Q17. Lymphomes a petites cellules

En immunohistochimie, les cellules néoplasiques du lymphome folliculaire :

- A) Expriment CD20 et CD10.

- B) Sont négatives pour CD3.
- C) Sont positives pour Bcl-2.
- D) Expriment le CD21 au niveau des cellules néoplasiques.
- E) Ont un Ki-67 corrélé au grade histologique.

Q18. Cancer de l'estomac

Concernant les facteurs de risque du carcinome gastrique, quelles propositions sont exactes ?

- A) Infection à *Helicobacter pylori*.
- B) Consommation élevée de fruits frais.
- C) Antécédent de chirurgie gastrique.
- D) Syndrome de Lynch.
- E) Tabagisme.

Q19. Cancer de l'estomac

À propos du carcinome gastrique au stade précoce :

- A) Il infiltre la muqueuse et la sous-muqueuse.
- B) Le risque de métastases ganglionnaires est élevé.
- C) Il est souvent bien différencié.
- D) Il peut être traité par mucosectomie.
- E) Il est souvent associé à une architecture papillaire ou tubulaire.

Q20. Cancer de l'estomac

Quelles sont les caractéristiques histologiques du carcinome gastrique de type diffus ?

- A) Présence de cellules peu cohésives.
- B) Formation de tubes glandulaires bien différenciés.
- C) Présence de cellules en bague à chaton.
- D) Infiltration transmurale de la paroi gastrique.
- E) Présence de cellules plasmacytoïdes et/ou histiocytoïdes.

Q21. Tumeurs du rein

Parmi les tumeurs rénales de l'enfant suivantes, lesquelles sont classées à haut risque selon la SIOP ?

- A) Néphroblastome complètement nécrotique.
- B) Néphroblastome blastémateux.
- C) Tumeur rhabdoïde du rein.
- D) Néphroblastome avec anaplasie.
- E) Néphroblastome stromal.

Q22. Tumeurs du rein

Concernant le néphroblastome (NB), quelles affirmations sont correctes ?

- A) Il est bilatéral dans 95 % des cas.
- B) Son diagnostic est présomptif entre 7 mois et 8 ans.
- C) Il présente typiquement une architecture triphasique : blastémateuse, épithéliale, stromale.
- D) Il est souvent associé à des syndromes génétiques.
- E) Il faut évaluer le % de nécrose/régression causée par la chimiothérapie.

Q23. Gastrite

Quelles affirmations sont exactes à propos d'*Helicobacter pylori* ?

- A) C'est un bacille à Gram positif.
- B) Il se loge dans le mucus gastrique.
- C) Il prédomine au niveau du fundus.
- D) Il peut être visualisé au Giemsa.
- E) Il est responsable de gastrites, ulcères et cancers.

Q24. Gastrite

Le système de Sydney évalue quels critères ?

- A) Inflammation chronique.
- B) Activité par les polynucléaires éosinophiles.
- C) Métaplasie intestinale.
- D) Présence de granulome.
- E) Atrophie glandulaire.

Q25. Gastrite

Quelles sont les complications possibles d'une gastrite à HP ?

- A) Carcinome épidermoïde de l'oesophage.
- B) Ulcère gastrique.
- C) Lymphome de MALT.
- D) Adénocarcinome gastrique.
- E) Métaplasie intestinale.

Q26. Gastrite

À propos des gastrites auto-immunes, cochez les propositions exactes :

- A) Présence d'anticorps anti-cellules pariétales.
- B) Localisation prédominante dans l'antrum.

- C) Risque de maladie de Biermer.
- D) Caractérisée par la présence de polynucléaires neutrophiles.
- E) Présence d'une hyperchlorhydrie.

Q27. Cancers broncho-pulmonaires

Concernant l'adénocarcinome pulmonaire, quelles affirmations sont justes ?

- A) Il touche surtout les grands fumeurs.
- B) Il exprime TTF1 et Napsine A.
- C) Il est souvent périphérique.
- D) Il peut être précédé de lésions d'hyperplasie adénomateuse atypique.
- E) Il n'existe pas de corrélation entre les aspects histologiques et les anomalies moléculaires.

Q28. Cancers broncho-pulmonaires

Quelles affirmations sont exactes à propos des anomalies moléculaires de l'adénocarcinome pulmonaire ?

- A) Les mutations EGFR sont fréquentes chez les non-fumeurs.
- B) Le réarrangement ALK est exclusif d'une mutation EGFR.
- C) Les tests moléculaires sont inutiles en situation métastatique.
- D) Certaines mutations peuvent être mise en évidence par immunohistochimie.
- E) L'identification des anomalies moléculaires oriente la thérapie ciblée.

Q29. Cancers broncho-pulmonaires

Le carcinome épidermoïde se caractérise par :

- A) Production de kératine.
- B) Expression de CK5/6 et P63.
- C) Localisation distale exclusive.
- D) Expression de TTF1 et Napsine A.
- E) Lien étroit avec le tabagisme.

Q30. Cancers broncho-pulmonaires

A propos des tumeurs neuroendocrines pulmonaires cochez les propositions exactes :

- A) Elles sont toujours de mauvais pronostic.
- B) Elles expriment la chromogranine et la synaptophysine.
- C) Le carcinome à petites cellules constitue une urgence diagnostique.
- D) Le carcinoïde typique peut révéler des foyers de nécrose tumorale.
- E) L'index de prolifération (Ki67) joue un rôle primordial dans la classification.

Q31. Lymphome hodgkinien

Concernant les cellules de Reed-Sternberg, cochez les propositions vraies :

- A) Ce sont des cellules tumorales de grande taille à noyaux bilobés ou multilobés.
- B) Elles expriment classiquement CD15 et CD30.
- C) Elles sont spécifiques du lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire.
- D) Elles sont toujours abondantes dans les prélèvements histologiques.
- E) Leur origine est lymphocytaire B.

Q32. Lymphome hodgkinien

Parmi les propositions suivantes, quelles sont les formes histologiques reconnues du lymphome de Hodgkin (LH) classique selon l'OMS ?

- A) Scléro-nodulaire.
- B) Riche en lymphocytes.
- C) À déplétion lymphocytaire.
- D) Lymphome de Poppema Lennert.
- E) Cellularité mixte.

Q33. Lymphome hodgkinien

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies à propos des lésions observées en histologie dans le LH classique ?

- A) Les cellules tumorales sont rares dans un fond inflammatoire riche.
- B) On observe des granulomes épithélioïdes nécrosants typiques.
- C) Il existe parfois une fibrose collagène dans la forme scléronodulaire.
- D) Le fond peut contenir des polynucléaires, des lymphocytes et des éosinophiles.
- E) Les noyaux des cellules tumorales peuvent présenter un aspect en oeil de hibou.

Q34. Cancers colorectaux

Quels critères histologiques sont considérés comme facteurs de mauvais pronostic dans l'adénocarcinome colique ?

- A) Invasion vasculaire.
- B) Infiltration périnerveuse.
- C) Composante mucineuse.
- D) Atteinte ganglionnaire métastatique.
- E) Présence d'un fond inflammatoire lymphocytaire marqué.

Q35. Tumeurs de la vessie

Parmi les marqueurs suivants, lesquels sont classiquement exprimés dans les carcinomes urothéliaux de la vessie ?

- A) GATA3.
- B) CD30.

- C) CK7.
- D) PAX8.
- E) CDX2.

Q36. Tumeurs de la vessie

Quels éléments histologiques sont associés à un mauvais pronostic dans le carcinome urothélial vésical ?

- A) Invasion du muscle vésical.
- B) Présence d'embolies vasculaires tumorales.
- C) Composante sarcomatoïde.
- D) Présence d'une composante mucineuse.
- E) Architecture papillaire.

Q37. Cancers colorectaux

Quels des éléments suivants font partie des critères histopronostiques pris en compte dans la classification TNM du cancer colorectal ?

- A) Profondeur de l'invasion pariétale.
- B) Nombre de ganglions envahis.
- C) Degré de différenciation tumorale.
- D) Taille maximale de la tumeur en cm.
- E) Présence d'embolies vasculaires tumorales.

Q38. Tumeurs du rein

Voici une partie d'un compte rendu anatomopathologique d'une pièce de néphrectomie totale : Il s'agit d'une prolifération tumorale carcinomateuse montrant une architecture alvéolaire et trabéculaire au sein d'un stroma fibro-vasculaire abondant. Les cellules tumorales ont un cytoplasme abondant optiquement clair et des noyaux augmentés de taille avec présence d'un nucléole visible au faible grossissement (x10). Le grade nucléolaire de l'ISUP est :

- A) Grade 1.
- B) Grade 2.
- C) Grade 3.
- D) Grade 4.
- E) Grade nucléolaire non applicable pour ce type de tumeur.

Q39. Tumeurs du rein

Quel est le type histologique le plus fréquent des tumeurs rénales ?

- A) Carcinome papillaire.
- B) Carcinome chromophile.
- C) Angiosarcome.
- D) Carcinome épidermoïde.
- E) Carcinome à cellules claires.

Q40. Cancers colorectaux

Un adénocarcinome colique infiltrant la paroi colique jusqu'à la musculature est classé :

- A) pT2.
- B) pT3.
- C) pT1.
- D) pT4a.
- E) pTins.

Q41. MICI

Quels sont les critères histologiques en faveur d'une rectocolite hémorragique (RCH) ?

- A) Atteinte inflammatoire transmurale.
- B) Présence de granulomes épitélioides non caséux.
- C) Inflammation continue sans zones saines.
- D) Fissures et ulcérations profondes.
- E) Atteinte rectale microscopique constante.

Q42. MICI

Parmi ces complications, laquelle est plus fréquente dans la RCH que dans la Maladie de Crohn ?

- A) Sténoses intestinales.
- B) Dysplasie/Adénocarcinome colorectal.
- C) Fistules entéro-cutanées.
- D) Maladie péri-anale.
- E) Atteinte iléale.

Q43. MICI

Quelle stratégie de prélèvement est recommandée pour les biopsies dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin MICI ?

- A) Prélèvements biopsiques étagés (iléon, côlon droit, gauche, rectum).
- B) Au moins 2 biopsies par site, incluant zones lésées et la muqueuse saine.
- C) Biopsies exclusivement sur les ulcérations profondes.
- D) Éviter les biopsies en cas de poussée sévère (risque de perforation).
- E) Prélèvements uniquement rectaux en cas de suspicion de RCH.

Q44. Polype et polyposé

Parmi ces propositions, laquelle est fausse concernant les polyposes digestives ?

- A) La polypose hyperplasique est associée à un risque élevé de cancer colorectal.
- B) Le syndrome de Cronkhite-Canada associe des polypes hamartomateux et une dystrophie unguéale.
- C) La polypose adénomateuse familiale (PAF) est liée à une mutation germinale du gène APC.
- D) La PAF est associée à un risque accru d'adénocarcinome colorectal.
- E) Le syndrome de Peutz-Jeghers est dû à une Mutation du gène STK11/LKB1.

Q45. Polype et polypose

On distingue parmi les polypes simples non épithéliaux :

- A) Polype Juvénile.
- B) Adénome tubuleux.
- C) Polype hyperplasique.
- D) Lésion festonnée sessile.
- E) Polype inflammatoire.

Q46. Polype et polypose

À propos de la séquence polype-cancer dans le côlon :

- A) Crypte aberrante -> Adénome dysplasie de bas grade -> Adénome en dysplasie de haut grade -> Adénocarcinome.
- B) Polype hyperplasique -> Adénome tubuleux -> adénocarcinome.
- C) Inflammation chronique -> Dysplasie -> Cancer.
- D) Atrophie muqueuse -> Métaplasie intestinale -> adénocarcinome.
- E) Les adénomes plans dégénèrent plus souvent que les adénomes tubuleux.

Q47. Polype et polypose

Quels critères histologiques définissent une dysplasie de haut grade dans un adénome colorectal ?

- A) Noyaux stratifiés sur toute la hauteur de l'épithélium.
- B) Augmentation de l'activité mitotique avec mitoses atteignant la surface.
- C) Perte de polarité nucléaire.
- D) Invasion de la sous-muqueuse.
- E) Conservation de la mucosécrétion épithéliale.

Q48. Cancer de prostate

Le score de Gleason :

- A) Est obtenu en additionnant les 2 grades histologiques le plus représenté et le plus agressif dans la tumeur.
- B) Est un score histo-pronostique caractérisant le degré de différenciation de la tumeur.
- C) Sur Biopsie : 80% grade 3, 15% grade 4, 5% grade 5 -> Score 3+4=7 + mention du grade tertiaire 5.
- D) Sur pièce opératoire, un contingent de grade 5 minoritaire (moins de 5% du volume total) par rapport aux contingents de grade 3 et 4, doit être mentionné sous forme d'un grade tertiaire.
- E) Un core de Gleason 6 correspond aux cancers de prostate bien différenciés de Grade Group 1 de l'ISUP.

Q49. Cancer de l'endomètre

Les tumeurs épithéliales malignes de l'ovaire :

- A) Sont dominées par les carcinomes séreux.
- B) Le carcinome séreux de bas grade se caractérise par une mutation de KRAS ou BRAF.
- C) Les carcinomes mucineux ovariens posent problème de diagnostic différentiel avec une origine digestive.
- D) Un carcinome séreux de bas grade est souvent associé à des foyers de tumeur séreuse borderline.
- E) Les carcinomes séreux de haut grade ovariens présentent le profil immunohistochimique suivant : CK7+, CK20-, PAX8+, WT1+, P53 muté.

Q50. Cancer de l'endomètre

Sur le plan microscopique, le cystadénocarcinome séreux de haut grade l'ovaire, est caractérisé par :

- A) Une architecture glandulaire, papillaire ou solide.
- B) Atypies cytonucléaires faibles.
- C) Mitoses souvent très nombreuses.
- D) Non invasion du stroma.
- E) Présence fréquente de psammomes.

RATTRAPAGE 2025

Q51. Cancer du sein

Quelle caractéristique histologique est typique d'un carcinome lobulaire invasif ?

- A) présence de carcinome in situ.
- B) cellules tumorales non cohésives.
- C) Architecture glandulaire bien formée.
- D) Stroma desmoplasique marqué.
- E) Infiltrat lymphocytaire important.

Q52. Cancer du sein

Quels éléments sont des critères du score de Nottingham (grade histologique SBR) ? (Trouvez l'intrus)

- A) Formation de structures glandulaires.
- B) Pléomorphisme nucléaire.

- C) Index mitotique.
- D) Infiltrat lymphocytaire.
- E) Expression de HER2.

Q53. Cancer du sein

Sur le plan immunohistochimique, quelle(s) est (sont) le (les) caractéristiques d'un carcinome lobulaire ?

- A) Perte des récepteurs hormonaux.
- B) Perte de E-cadherine.
- C) Expression de p53.
- D) Ki67 très élevé.
- E) Gain de la CK5/6.

Q54. Cancer du sein

Pour les tumeurs HER2 positives, quelle(s) est (sont) sa (ses) particularité ?

- A) Facteur prédictif de réponse à l'Herceptin.
- B) Facteur prédictif de pCR.
- C) Les cellules ne surexpriment pas la protéine HER.
- D) Tumeurs de bon pronostic.
- E) Traitement néoadjuvant.

Q55. Cancer du sein

Quels facteurs influencent le pronostic du cancer du sein ? (Trouvez l'intrus)

- A) Statut ganglionnaire.
- B) Grade histologique.
- C) Statut des récepteurs hormonaux.
- D) Taille des cellules tumorales.
- E) Index Ki-67.

Q56. Cancer du col de l'utérus

Quelle(s) est (sont) le (les) lésion(s) précancéreuse (s) (ou précurseur) dans le carcinome épidermoïde du col ?

- A) LSIL avec un HPV de haut risque.
- B) LSIL avec un HPV de bas risque.
- C) Néoplasie intra-épithéliale cervicale (ou CIN).
- D) Métaplasie malpighienne physiologique.
- E) Polype endocervical.

Q57. Cancer du col de l'utérus

Quels facteurs de risques sont associés au cancer du col ?

- A) Infection persistante par HPV.
- B) Tabagisme.
- C) Multiparité seule (sans HPV).
- D) Immunodépression (VIH).
- E) Utilisation de DIU au cuivre.

Q58. Cancer du col de l'utérus

Quelles propositions sont vraies concernant le CIN :

- A) La CIN3 est un équivalent histologique d'HSIL.
- B) La CIN1 régresse toujours.
- C) La progression vers le cancer dépend du génotype HPV.
- D) Le traitement peut inclure une conisation.
- E) La CIN2 est toujours traitée par hystérectomie.

Q59. Cancer du col de l'utérus

Pour le FCU :

- A) On peut réaliser le FCU conventionnel.
- B) On peut réaliser le FCU en monocouche ou en milieu liquide.
- C) Le FCU se fait après le toucher vaginal.
- D) Le FCU conventionnel permet la recherche d'HPV.
- E) Il peut être fait pendant les menstruations.

Q60. Cancer du col de l'utérus

Quels examens complémentaires sont utiles pour un FCU avec un ASC-US ?

- A) Colposcopie avec biopsie.
- B) Test HPV.
- C) IRM pelvienne.
- D) Frottis vaginal seul.
- E) Répétition du FCU à 3 ans.

Q61. Tumeurs du rein

Concernant le carcinome à cellules claires du rein : (Trouvez l'intrus)

- A) Il représente la forme la plus fréquente des carcinomes rénaux.
- B) Il est souvent associé à une inactivation du gène VHL.
- C) Il montre typiquement une architecture trabéculaire, en nids ou alvéolaire.

- D) Il est toujours de bas grade nucléaire de Fuhrman (grade ISUP).
E) Il a souvent un stroma hypovasculaire à l'histologie.

Q62. Tumeurs du rein

Concernant le carcinome chromophile :

- A) Il représente la forme histologique la plus fréquente des tumeurs rénales de l'adulte.
B) Il est richement vascularisé.
C) Il montre sur le plan cytologique un aspect pseudo-koilocytaire.
D) Il a un meilleur pronostic que le carcinome à cellules claires.
E) Il est souvent associé à une infection à papillomavirus humain (HPV).

Q63. Tumeurs du rein

Concernant les marqueurs immunohistochimiques dans les tumeurs rénales :

- A) Le PAX8 est un marqueur de différenciation rénale.
B) CD10 est fréquemment exprimé dans le carcinome à cellules claires.
C) Le GATA 3 est souvent exprimé par les carcinomes chromophobes.
D) CK7 est toujours exprimé par les tumeurs rénales.
E) L'étude immunohistochimique n'est pas nécessaire pour le diagnostic.

Q64. Tumeurs de la vessie

Concernant le carcinome urothélial de la vessie : (Trouvez l'intrus)

- A) Il est fréquent chez les personnes tabagiques chroniques.
B) Il peut être de bas grade ou de haut grade.
C) Il nécessite systématiquement une cystectomie.
D) Il ne donne jamais de métastases ganglionnaires.
E) Il peut présenter une composante in situ associée.

Q65. Tumeurs de la vessie

Un carcinome urothélial de stade pT2 :

- A) Est toujours de haut grade.
B) Souvent associé à un carcinome in situ (CIS).
C) Nécessite en principe une cystectomie.
D) Sur le plan histologique, il se caractérise par une tumeur qui infiltre le muscle Détrusor.
E) La cystectomie n'est pas systématique.

Q66. Tumeurs de la vessie

Immunohistochimie dans les tumeurs vésicales :

- A) Le GATA3 est un marqueur sensible du carcinome urothélial.
B) Le P63 peut être exprimé dans le carcinome urothélial.
C) Le CK7 est toujours négatif dans les tumeurs urothéliales.
D) Le CDX2 est souvent exprimé dans les carcinomes urothéliaux.
E) Le PAX 8 est souvent exprimé par les carcinomes urothéliaux.

Q67. Tumeurs de la vessie

Concernant la classification TNM des tumeurs de la vessie, une tumeur urothéliale stade pT1 correspond à :

- A) Une atteinte du chorion sans envahissement musculaire.
B) Une atteinte du muscle superficiel.
C) Une extension dans la graisse périvésicale macroscopique.
D) Une infiltration du muscle profond.
E) Une atteinte de la prostate ou de l'utérus.

Q68. Cancers colorectaux

Concernant les caractéristiques histologiques de l'adénocarcinome colique :

- A) Il dérive le plus souvent d'un adénome préexistant.
B) Il est toujours localisé dans le colon gauche.
C) Il est toujours bien différencié.
D) Il peut présenter un contingent mucineux.
E) Il est souvent associé à une réaction des lymphocytes intra-épithéliaux.

Q69. Cancers colorectaux

À propos du score de différenciation tumorale dans le cancer colorectal :

- A) Il se base principalement sur l'architecture glandulaire.
B) Un adénocarcinome bien différencié présente >95% de structures glandulaires.
C) Le grade n'a aucune valeur pronostique.
D) Les adénocarcinomes peu différenciés ont un risque métastatique plus élevé.
E) Le grade histologique est intégré dans la stadification TNM.

Q70. Cancers colorectaux

Concernant l'immunohistochimie dans le cancer colorectal :

- A) Le CK20 est fréquemment exprimé dans les adénocarcinomes coliques.
B) Le CDX2 est un marqueur souvent exprimé par les adénocarcinomes colorectaux.
C) L'expression du MMR (Mismatch Repair) est testée pour détecter une instabilité microsatellitaire (MSI).
D) L'expression de la CK7 est constante.

E) Le PAX8 est toujours exprimé dans le cancer colorectal.

Q71. Cancers colorectaux

À propos de la classification pTNM des cancers coliques, une tumeur classée pT3 correspond à :

- A) Une infiltration de la sous-muqueuse.
- B) Une infiltration de la musculuse.
- C) Une infiltration de la sous-séreuse.
- D) Une infiltration du péritoine viscéral.
- E) Une infiltration directe d'un organe adjacent.

Q72. Cancers colorectaux

Facteurs histopronostiques importants dans le cancer colorectal à précisés dans un compte rendu anatomopathologique sont :

- A) L'envahissement vasculaire ou lymphatique.
- B) L'extension tumorale (pT).
- C) Le statut microsatellite (MSI).
- D) La marge de résection (R0 vs R1).
- E) L'expression de l'index de prolifération Ki67.

Q73. Lymphome hodgkinien

Marqueurs immunohistochimiques dans le lymphome de Hodgkin classique sont :

- A) CD30.
- B) CD15.
- C) CD20 est toujours fortement exprimé.
- D) CK7 est parfois exprimé.
- E) CD3 est typiquement exprimé par les cellules tumorales.

Q74. Cancers broncho-pulmonaires

Les biopsies dans le cadre des cancers pulmonaires :

- A) Sont toujours chirurgicales.
- B) Le choix de la technique dépend souvent du siège de la tumeur.
- C) Les zones nécrotiques permettent une bonne analyse anatomopathologique.
- D) La biopsie transpariétale est indiquée pour les tumeurs périphériques.
- E) Le diagnostic anatomopathologique se base sur la morphologie uniquement.

Q75. Cancers broncho-pulmonaires

A propos des cancers pulmonaires, cochez les propositions exactes :

- A) Ils sont souvent diagnostiqués au stade métastatique.
- B) Le carcinome à grande cellules est un diagnostic d'exclusion.
- C) L'étude immunohistochimique est non indispensable pour les tumeurs peu différenciées.
- D) L'anatomopathologiste joue un rôle crucial en pré, per et post-opératoire.
- E) Les tests moléculaires sont parfois obligatoires au moment du diagnostic en cas de cancer métastatique.

Q76. Cancers broncho-pulmonaires

L'adénocarcinome broncho-pulmonaire se caractérise par :

- A) Production de kératine.
- B) Expression de TTF1 et Napsine A.
- C) Localisation souvent proximale.
- D) Expression de P40.
- E) Présence de corrélation entre les aspects histologiques et les anomalies moléculaires.

Q77. Cancers broncho-pulmonaires

Quels sont les facteurs pronostiques des cancers pulmonaires pris en compte par l'anatomopathologiste ?

- A) Le type histologique de la tumeur.
- B) Les antécédents du patient.
- C) Le stade TNM.
- D) Le curage ganglionnaire.
- E) La qualité de l'exérèse chirurgicale.

Q78. Cancers broncho-pulmonaires

Quels marqueurs immunohistochimiques sont utilisés pour différencier un carcinome épidermoïde d'un adénocarcinome pulmonaire ?

- A) Synaptophysine.
- B) TTF-1.
- C) P40.
- D) Chromogranine A.
- E) CD56.

Q79. Cancers broncho-pulmonaires

Parmi les propositions suivantes lequel de ces types histologiques est plus fréquent au niveau du poumon ?

- A) Sarcome.
- B) Adénocarcinome.
- C) Mélanome.
- D) Lymphome.
- E) Carcinome neuroendocrine.

Q80. Tumeurs du rein

Quel est le rôle du pathologiste dans la prise en charge des tumeurs rénales de l'enfant ?

- A) Évaluer le stade selon la classification de l'OMS.
- B) Identifier le type histologique de la tumeur.
- C) Confirmer le diagnostic tumoral.
- D) Déterminer le groupe de risque selon la SIOP (Société Internationale d'Oncologie Pédiatrique).
- E) Décider seul de la chimiothérapie à administrer.

Q81. Tumeurs du rein

Parmi ces tumeurs rénales, lesquelles intéressent préférentiellement l'enfant ?

- A) Sarcome à cellules claires.
- B) Tumeur rhabdoïde du rein.
- C) Carcinome à cellules rénales.
- D) Néphroblastome.
- E) Néphrome mésoblastique.

Q82. Gastrite

A propos des gastrites chroniques à *Helicobacter Pylori* (HP), cochez les propositions exactes :

- A) Prédomine au niveau du fundus.
- B) Peut évoluer vers l'atrophie.
- C) Sont souvent asymptomatiques.
- D) Caractérisées par la corrélation endoscopie-histologie.
- E) Peut évoluer vers la dysplasie.

Q83. Gastrite

Les gastrites chroniques d'activité légère sont définies par la présence de polynucléaires neutrophiles au niveau de :

- A) Chorion intercryptique.
- B) L'épithélium glandulaire.
- C) La lumière glandulaire.
- D) Capillaires.
- E) Chorion interglandulaire.

Q84. Gastrite

L'intensité des gastrites chroniques se définit par la présence au niveau du chorion de :

- A) Lymphocytes.
- B) Plasmocytes.
- C) Macrophages.
- D) Polynucléaires neutrophiles.
- E) Polynucléaires éosinophiles.

Q85. Gastrite

A propos de l'*Helicobacter pylori*, cochez les propositions exactes :

- A) Recherché systématiquement surtout si la gastrite est active.
- B) Mieux mis en évidence par le Bleu-Alcian.
- C) Il peut être révélé par l'immunohistochimie.
- D) Sensibilité et spécificité de l'examen anatomopathologique est faible.
- E) Il est retrouvé surtout au fond des cryptes.

Q86. Gastrite

A propos des gastrites granulomateuses, quelles sont les bonnes réponses ?

- A) Granulomes parfois nécrosants avec cellules géantes.
- B) Souvent liée à la tuberculose ou maladie de Crohn.
- C) Se voit exclusivement sans *Helicobacter Pylori* (HP).
- D) Peut-être non infectieuse (réaction à corps étranger).
- E) Peut évoluer vers la maladie de Biermer.

Q87. Adénites

Concernant les adénites infectieuses suppurées :

- A) Les germes les plus fréquents sont Staphylocoques et Streptocoques.
- B) Les ganglions atteints drainent souvent un site d'infection suppurée.
- C) Les granulomes nécrosants sont caractéristiques.
- D) On observe des infiltrats de PNN et parfois des micro-abcès.
- E) Le germe peut être visible en microscopie après coloration spéciale.

Q88. Adénites

Concernant les adénites granulomateuses chroniques :

- A) Les granulomes peuvent être nécrosants ou non nécrosants.
- B) Le granulome tuberculoïde nécrosant est typique de la sarcoïdose.
- C) Le granulome à corps étranger contient souvent du talc ou des sutures.
- D) La PCR peut identifier l'agent infectieux.
- E) La présence de cellules géantes est fréquente.

Q89. Adénites

Concernant l'adénite tuberculeuse :

- A) Le granulome présente une nécrose caséuse au centre.
- B) La contamination se fait par contact avec une personne infectée.
- C) Les calcifications peuvent apparaître en phase de guérison.
- D) La coloration de Grocott est spécifique du BK.
- E) Les cellules géantes de Langhans sont souvent présentes.

Q90. Adénites

Concernant la sarcoïdose :

- A) Les granulomes sont non nécrosants.
- B) L'ECA est souvent augmentée.
- C) Les granulomes comportent un infiltrat neutrophilique dense.
- D) Le rapport CD4/CD8 est souvent >4:1.
- E) Le diagnostic repose uniquement sur l'histologie.

Q91. Adénites

Quels sont les éléments utiles au diagnostic différentiel entre un lymphome folliculaire et une hyperplasie folliculaire réactionnelle ?

- A) Présence de macrophages à corps tingibles.
- B) Taux de mitoses dans les follicules.
- C) Polarité du centre germinatif.
- D) Expression de Bcl-2 dans le centre germinatif.
- E) Expression de CD10 dans la zone du manteau.

Q92. Lymphomes a petites cellules

Quels sont les facteurs de mauvais pronostic du lymphome folliculaire ? (Trouvez l'intrus)

- A) Atteinte de la moelle osseuse.
- B) Ganglion > 6 cm.
- C) Hémoglobine > 13 g/dl.
- D) Index de prolifération élevé.
- E) Mutation TP53.

Q93. Lymphomes a petites cellules

À propos des options thérapeutiques dans le lymphome folliculaire :

- A) Le protocole R-CHOP est indiqué en première ligne pour tous les patients.
- B) La radiothérapie peut être proposée en stade I ou II.
- C) Le « Watch and wait » est réservé aux patients symptomatiques.
- D) Le rituximab fait partie du protocole de chimiothérapie.
- E) Le traitement dépend du stade et de la charge tumorale.

Q94. Cancer de l'estomac

Concernant les moyens diagnostiques du cancer gastrique :

- A) La classification de Paris s'applique aux cancers gastriques avancés.
- B) La classification de Bormann concerne les formes avancées.
- C) L'endoscopie peut révéler un aspect de linité plastique.
- D) L'immunohistochimie peut inclure l'étude de Her2.
- E) La TDM est inutile pour le diagnostic.

Q95. Cancer de l'estomac

Quelles affirmations sont vraies concernant les diagnostics différentiels du carcinome gastrique ?

- A) Une dysplasie gastrique se distingue par l'absence de desmoplasie.
- B) Un lymphome gastrique exprime CD45 et est négatif pour la cytokératine.
- C) Un xanthome gastrique exprime CK+ et CD68+.
- D) Une maladie de Whipple peut simuler un carcinome.
- E) Un carcinome métastatique gastrique peut être difficile à différencier d'un primitif.

Q96. Cancer de l'estomac

Parmi les éléments pronostiques du cancer gastrique, on retrouve :

- A) Le type histologique (intestinal vs diffus).
- B) La différenciation tumorale.
- C) L'envahissement péri-nerveux.
- D) La présence d'*Helicobacter pylori*.
- E) Les embolies vasculaires.

Q97. Cancer de l'estomac

Concernant les facteurs de risque du carcinome gastrique, quelles propositions sont exactes ?

- A) Infection à *Helicobacter pylori*.
- B) Consommation élevée de fruits frais.
- C) Antécédent de chirurgie gastrique.
- D) Syndrome de Lynch.
- E) Tabagisme.

Q98. Cancer de l'estomac

À propos du carcinome gastrique au stade précoce : (Trouvez l'intrus)

- A) Il infiltre la muqueuse et la sous-muqueuse.
- B) Le risque de métastases ganglionnaires est élevé.
- C) Il est souvent bien différencié.
- D) Il peut être traité par mucosectomie.
- E) Il est souvent associé à une architecture papillaire ou tubulaire.

Q99. Cancer de l'estomac

Quelles sont les caractéristiques histologiques du carcinome gastrique de type diffus ?

- A) Présence de cellules peu cohésives.
- B) Formation de tubes glandulaires bien différenciés.
- C) Présence de cellules en bague à chaton.
- D) Infiltration transmurale de la paroi gastrique.
- E) Présence de cellules plasmacytoïdes et/ou histiocytoïdes.

Q100. Lymphome hodgkinien

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies à propos des lésions observées en histologie dans le LH classique ?

- A) Les cellules tumorales sont rares dans un fond inflammatoire riche.
- B) On observe des granulomes épithélioïdes nécrosants typiques.
- C) Il existe parfois une fibrose collagène dans la forme scléronodulaire.
- D) Le fond peut contenir des polynucléaires dans la forme riche en lymphocytes.
- E) Les noyaux des cellules tumorales peuvent présenter un aspect en oeil de hibou.

DÉCEMBRE 2024 (RATTRAPAGE)

Q101. Adénites

Quels sont les trois types principaux d'adénites selon leur étiologie ?

- A) Adénites réactionnelles.
- B) Adénites infectieuses.
- C) Adénites inflammatoires.
- D) Adénites tumorales.
- E) Adénites auto-immunes.

Q102. Adénites

Quelles colorations spéciales sont utilisées pour le diagnostic des adénites infectieuses ?

- A) Ziehl-Neelsen pour les bacilles acido-alcool-résistants.
- B) PAS pour les polysaccharides.
- C) Grocott pour les champignons.
- D) Gram pour les bactéries.
- E) Giemsa pour les parasites.

Q103. Adénites

Quelle méthode est indispensable pour analyser les anomalies structurelles des ganglions ?

- A) Anatomie pathologique.
- B) Imagerie IRM.
- C) Lavage broncho-alvéolaire.
- D) Test génétique.
- E) Immunohistochimie.

Q104. Adénites

Quelles sont les caractéristiques des hyperplasies folliculaires réactionnelles ?

- A) Polarité des follicules conservée.
- B) Follicules élargis mais distincts.
- C) Perte complète de la structure folliculaire.
- D) Présence d'un infiltrat inflammatoire polymorphe.
- E) Apparition de centres germinatifs actifs.

Q105. Adénites

Quels agents infectieux causent une adénite granulomateuse ?

- A) Mycobacterium tuberculosis.
- B) Bartonella henselae.
- C) Histoplasma capsulatum.
- D) Virus de la grippe.
- E) Brucella spp.

Q106. Adénites

Quels diagnostics différentiels sont associés aux adénites granulomateuses ?

- A) Sarcoidose.
- B) Tuberculose.
- C) Maladie des griffes du chat.
- D) Lymphome.
- E) Histoplasmose.

Q107. Lymphomes a petites cellules

Quelle translocation est clé dans la lymphomagenèse du lymphome folliculaire ?

- A) t(14;18).
- B) t(9;22).
- C) t(11;14).
- D) t(8;14).
- E) t(3;14).

Q108. Lymphomes a petites cellules

Quels facteurs génétiques augmentent le risque de lymphome folliculaire ?

- A) Mutation germinale du locus 6p21.3.
- B) Prédisposition familiale directe.
- C) Amplification de Bcl-2.
- D) Mutation TP53.
- E) Variation du HLA-DQ locus.

Q109. Lymphomes a petites cellules

Quels marqueurs pan-B sont utilisés en immunohistochimie pour diagnostiquer un lymphome folliculaire ?

- A) CD20.
- B) CD19.
- C) CD22.
- D) CD15.
- E) Pax-5.

Q110. Lymphomes a petites cellules

Quels lymphomes appartiennent aux néoplasmes à cellules B matures ?

- A) Leucémie lymphoïde chronique.
- B) Lymphome du manteau.
- C) Lymphome diffus à grandes cellules B.
- D) Lymphome de Hodgkin.
- E) Lymphome de Burkitt.

Q111. Gastrite

Quels virus peuvent être responsables de gastrites infectieuses ?

- A) Herpès simplex virus.
- B) Cytomégalo virus (CMV).
- C) Virus de l'hépatite A.
- D) Virus de l'hépatite C.
- E) Virus d'Epstein-Barr (EBV).

Q112. Gastrite

Quelle est la localisation préférentielle de HP dans l'estomac ?

- A) Fundus.
- B) Antre.
- C) Cardia.
- D) Toute la muqueuse gastrique.
- E) Pylore.

Q113. Gastrite

Quel est le risque relatif de cancer gastrique chez les patients porteurs de HP ?

- A) Multiplié par 2.
- B) Multiplié par 3 à 6.
- C) Multiplié par 8.
- D) Multiplié par 10.
- E) Multiplié par 12.

Q114. Gastrite

Quelles complications sont associées à une gastrite chronique à HP ?

- A) Métaplasie intestinale.
- B) Atrophie glandulaire.
- C) Cancer gastrique.
- D) Lymphome de MALT.
- E) Ulcère gastrique ou duodénal.

Q115. Gastrite

Quels sont les signes histologiques typiques d'une gastrite à HP ?

- A) Inflammation chronique avec cryptites.
- B) Présence de follicules lymphoïdes.
- C) Métaplasie intestinale.
- D) Ulcérations profondes.
- E) Hyperplasie foveolaire.

Q116. Cancer de l'estomac

Quelle est la définition de l'adénocarcinome gastrique ?

- A) Une tumeur épithéliale bénigne.
- B) Une tumeur maligne primitive de l'estomac.
- C) Une tumeur neuroendocrine.
- D) Une métastase gastrique.
- E) Une lésion précancéreuse.

Q117. Cancer de l'estomac

Quels sont les facteurs influençant l'incidence de l'adénocarcinome gastrique ?

- A) Origine géographique.
- B) Niveau socio-économique.
- C) Prédispositions génétiques.
- D) Niveau de pollution.
- E) Consommation de tabac et d'alcool.

Q118. Cancer de l'estomac

Quels agents infectieux sont liés au développement de l'adénocarcinome gastrique ?

- A) Helicobacter pylori.
- B) Virus Epstein-Barr.
- C) Streptococcus pneumoniae.
- D) Candida albicans.
- E) Mycobacterium tuberculosis.

Q119. Cancer de l'estomac

Quelle caractéristique définit un carcinome gastrique de type diffus ?

- A) Présence de cellules en bague à chaton.
- B) Formation de tubes glandulaires.
- C) Prolifération cohésive des cellules tumorales.
- D) Infiltration des couches profondes de la paroi gastrique.
- E) Production excessive de mucine intra-tumorale.

Q120. Cancer de l'estomac

Quelle est la survie à 5 ans pour un cancer gastrique au stade précoce ?

- A) 30 %.
- B) 50 %.
- C) 90 %.
- D) 70 %.
- E) 80 %.

Q121. MICI

Sur une pièce opératoire d'iléon réséqué pour maladie de Crohn grave ou compliquée :

- A) L'inflammation n'est retrouvée que dans la muqueuse.
- B) Les lésions sont segmentaires, avec des intervalles sains.
- C) Les ulcérations et les saignements intra muqueux sont marqués.
- D) La présence de granulomes épithélio-giganto-cellulaires est typique mais inconstante.
- E) Des fissures profondes sont possibles.

Q122. MICI

Sur une pièce opératoire recto-sigmoïdienne réséquée pour recto-colite hémorragique (RCH) grave :

- A) L'inflammation est prédominante au niveau de la muqueuse.
- B) Les lésions sont segmentaires, avec des intervalles sains.
- C) Les ulcérations et les saignements intra muqueux sont marqués.
- D) La présence de granulomes épithélio-gigantocellulaires est typique.
- E) Les polypes et pseudo-polypes peuvent contenir des foyers de dysplasie épithéliale.

Q123. MICI

L'examen anatomopathologique en cas de maladie de Crohn montre :

- A) Des lésions inflammatoires chroniques continues le long du rectosigmoïde.
- B) Des lésions inflammatoires chroniques dans toutes les tuniques de la paroi digestive.
- C) Des microabcès cryptiques nombreux.
- D) Des granulomes épithélio-gigantocellulaires occasionnels.
- E) De possibles sténoses pseudo-tumorales de l'iléon.

Q124. Cancer du col de l'utérus

Cocher les réponses justes. Le carcinome infiltrant du col utérin :

- A) Survient de novo, sur une muqueuse saine.
- B) Est fréquemment de type carcinome épidermoïde.
- C) Se manifeste habituellement par des métastases à distance.
- D) S'étend fréquemment à la muqueuse endométriale.
- E) Est précédé le plus souvent par des lésions précancéreuses acquises.

Q125. Cancer du col de l'utérus

Cochez les bonnes réponses. Les infections à papilloma virus humain (HPV) :

- A) Entraînent des condylomes pour les types d'HPV à faible risque.
- B) Sont diagnostiquées par les frottis cervico - utérins (FCU).
- C) Leur typage est possible sur FCU.
- D) Peuvent évoluer vers des lésions précancéreuses ou du cancer pour certains types de virus.
- E) L'HPV 16 et 18 sont responsables de la majorité des cas de cancer du col de l'utérus.

Q126. Cancer du col de l'utérus

Cocher la réponse juste. L'examen d'un FCU retrouve des cellules koilocytaires indiquant la présence d'une lésion virale de type HPV. Dans la classification de Bethesda 2014 cette lésion sera classée comme :

- A) Un ASCUS.
- B) Modification réactionnelle bénigne.
- C) Une lésion intra-épithéliale de bas grade.
- D) Une lésion intra-épithéliale de haut grade.
- E) Comme lésion inflammatoire spécifique.

Q127. Cancer du col de l'utérus

Le frottis cervico-utérin de dépistage doit être fait (cocher les bonnes réponses):

- A) A distance de tout rapport sexuel.
- B) En l'absence de saignement.
- C) A distance d'un traitement local.
- D) Lors d'une infection.
- E) Et si nécessaire, après traitement, oestrogénique chez la femme ménopausée.

Q128. Cancer du col de l'utérus

Le dépistage du cancer du col utérin a pour but de :

- A) Donner un diagnostic exact d'un cancer du col.
- B) Détecter un cancer du col à un stade précoce.
- C) Détecter la présence d'une lésion dysplasique.
- D) Sélectionner des femmes à haut risque du cancer du col.
- E) Réduire l'incidence du cancer du col utérin.

Q129. Polype et polypose

A propos de la séquence polype-cancer dans le côlon :

- A) Dans la polypose colorectale familiale, une dégénérescence maligne est presque systématique avant 40 ans.
- B) Les degrés de dysplasie s'évaluent en 3 grades.
- C) Les polypes adénomateux sont le plus sujets à dégénérer.
- D) Tout polype colique découvert doit faire proposer une consultation en génétique.
- E) Un foyer de cancer sur polype, infiltrant la sous-muqueuse, correspond à un carcinome invasif classé pT1.

Q130. Polype et polypose

L'analyse anatomo-pathologique d'un polype colique :

- A) Rassure en cas de polype de Peutz-Jeghers, car ces polypes ne dégénèrent pas.
- B) Doit préciser le degré de dysplasie en cas d'adénome colique.
- C) Doit rechercher la présence d'embolies vasculaires et de budding tumor en cas d'adénome cancérisé.
- D) Doit décrire l'état des marges d'exérèse, en cas d'adénome.
- E) Doit indiquer le niveau d'infiltration et l'aspect du pied, en cas de polype pédiculé cancérisé.

Q131. Polype et polypose

On distingue parmi les polypes simples épithéliaux les :

- A) Polype de Peutz-Jeghers.
- B) Polype inflammatoire.
- C) Adénomes villosités.
- D) Adénome festonné traditionnel.
- E) Polype hyperplasique.

Q132. Polype et polypose

Tout polype doit être :

- A) Bien orienté.
- B) Transfixié par une aiguille au niveau de sa tête pour son repérage.
- C) Inclus en totalité.
- D) Coupé de façon à obtenir la tête et le pied, de façon sagittale.
- E) Encre au niveau du pied (la limite d'exérèse).

Q133. Cancer de prostate

Le score de Gleason :

- A) Est un score histo-pronostique caractérisant le degré de différenciation de la tumeur.
- B) Est obtenu en additionnant les 2 grades histologiques les plus représentés et le plus agressif dans la tumeur.
- C) Sur pièce de prostatectomie, un contingent de grade 5 minoritaire (moins de 5% du volume total) par rapport aux contingents de grade 3 et 4, doit être mentionné sous forme d'un grade tertiaire.
- D) Scores de 8 à 10 correspondent aux cancers de prostate peu différenciés et de mauvais pronostic.
- E) Le Gleason 4 est défini par des glandes fusionnées et mal définies et/ou la présence de nappes de cellules indifférenciées.

Q134. Cancer de prostate

Les critères diagnostiques histologiques mineurs de l'adénocarcinome acinaire conventionnel sont :

- A) Rétraction péri-tumorale.
- B) Augmentation de la taille du noyau.
- C) Présence de cristalloïdes dans la lumière des glandes.
- D) Nucléole proéminent.
- E) Sécrétion éosinophile.

Q135. Cancer de prostate

Parmi les types histologiques suivants lesquels représentent des sous-types de l'adénocarcinome acinaire conventionnel ?

- A) Le néoplasie prostatique intra-épithéliale de haut grade.
- B) L'adenocarcinome prostatique ductal.
- C) L'adenocarcinome sarcomatoïde.
- D) L'adenocarcinome à cellules en bague à chaton.
- E) Carcinome intra-ductal de la prostate.

Q136. Tumeurs de l'ovaire

Pour les cystadénocarcinomes séreux de l'ovaire, le pronostic est lié aux :

- A) Présence d'embolies vasculaires.
- B) La présence de mutation P53.
- C) Extension d'organes de voisinage.
- D) Stade de FIGO.
- E) Grade histologique.

Q137. Tumeurs de l'ovaire

Les tumeurs épithéliales malignes de l'ovaire :

- A) Sont dominées par les carcinomes séreux.
- B) Le carcinome séreux de haut grade se caractérise par une mutation de la p53.
- C) Les carcinomes séreux sont gradés selon le grading de Malpika.
- D) Un carcinome séreux de haut grade est souvent associé à des foyers de tumeur séreuse borderline.
- E) Les carcinomes séreux ovariens de bas grade présentent le profil immunohistochimique suivant : CK7+, CK20-, PAX8+, WT1+, P53+.

Q138. Cancer de l'endomètre

Selon la classification moléculaire actuelle des cancers de l'endomètre :

- A) Deux types moléculaires sont reconnus : hormonodépendants et non hormonodépendants.
- B) Une désescalade thérapeutique pour les carcinomes d'endomètre POLE muté est possible.
- C) La recherche d'une instabilité micro-satellitaire est possible grâce à l'étude immunohistochimique.
- D) Les carcinomes endométriaux p53 muté, en l'absence de mutation POLE, ont le pronostic le plus fâcheux.
- E) Le type ultra-muté (POLE mutée) se caractérise par une charge mutationnelle très élevée et un mauvais pronostic.

Q139. Cancer de l'endomètre

Les informations que doit contenir un compte-rendu anatomopathologique d'une pièce d'hystérectomie pour carcinome endométrial :

- A) Le type histologique.
- B) Présence d'embolies vasculaire et lymphatique.
- C) L'état des ganglions.
- D) Extension au col, paramètres, annexes et autres organes pelviens.
- E) La profondeur d'invasion de l'endomètre.

Q140. Cancer de l'endomètre

Le carcinome endométrioïde de l'endomètre :

- A) Est le 1er cancer de l'endomètre par ordre de fréquence.
- B) Peut être composé de territoires solides occupant plus de la moitié de la tumeur dans les formes peu différenciées.
- C) Est marqué par la persistance du chorion cytogène.
- D) La présence d'une différenciation malpighienne écarte ce diagnostic.
- E) En cas d'atypies cytonucléaires importantes, un carcinome endométrioïde de G1 passe directement au grade 3.

Q141. Cancers broncho-pulmonaires

Quel type histologique des tumeurs pulmonaires est caractérisé par une prolifération de cellules de petites tailles rondes, largement écrasées avec présence de nécrose tumorale ?

- A) Carcinome épidermoïde.
- B) Carcinome à petites cellules.
- C) Adénocarcinome.
- D) Tumeur carcinoïde.
- E) Carcinome à grandes cellules.

Q142. Lymphome hodgkinien

Parmi les affirmations suivantes concernant le lymphome de Hodgkin, laquelle est correcte ?

- A) Le lymphome de Hodgkin est toujours diagnostiqué par une biopsie de moelle osseuse.
- B) La présence de cellules de Reed-Sternberg dans un prélèvement histologique est un critère clé pour le diagnostic du lymphome de Hodgkin.
- C) Le lymphome de Hodgkin survient principalement chez les adultes âgés de plus de 70 ans.
- D) Le pronostic est toujours mauvais.
- E) Le lymphome de Hodgkin est une forme de lymphome T.

Q143. Cancers broncho-pulmonaires

Parmi les anticorps suivants, lesquels sont souvent exprimés par les adénocarcinomes broncho-pulmonaires ?

- A) TTF-1.
- B) P63.
- C) Chromogranine A.
- D) CK7.
- E) GATA 3.

Q144. Tumeurs de la vessie

Quelle classification pathologique est utilisée pour grader les carcinomes urothéliaux ?

- A) Classification de Gleason.
- B) Classification de Fuhrman.
- C) Classification OMS/ISUP.
- D) Classification de Bethesda.
- E) Score de SBR modifié par Elis et Elston.

Q145. Lymphome hodgkinien

Le lymphome de Hodgkin pauvre en lymphocytes est associé à :

- A) Un meilleur pronostic.
- B) Un mauvais pronostic.
- C) Une absence de cellules tumorales.
- D) Une forte réaction immunitaire.
- E) Représente le sous type histologique le plus fréquent du lymphome de Hodgkin classique.

Q146. Lymphome hodgkinien

Quelles sont les cellules caractéristiques retrouvées dans un lymphome de Hodgkin ?

- A) Cellules de Reed-Sternberg.
- B) Cellules de Burkitt.
- C) Cellules lacunaires.
- D) Cellules de Sézary.
- E) Cellules de Hodgkin.

Q147. Cancers colorectaux

Le cancer colorectal évolue généralement à partir de :

- A) Polypes hyperplasiques.
- B) Polypes adénomateux.
- C) Diverticules coliques.
- D) Infections chroniques.
- E) Malformations congénitales.

Q148. Cancers colorectaux

Quelles sont les caractéristiques histopathologiques de l'adénocarcinome colorectal ?

- A) Présence de cellules géantes multinucléées.
- B) Différenciation glandulaire représentée essentiellement sous formes de structures tubulaires.
- C) Prolifération carcinomateuse avec présence de kératine.
- D) Prolifération tumorale diffuse à cellules rondes.
- E) Présence de cellules de type 'Reed-Sternberg'.

Q149. Cancers colorectaux

Le système de stadification TNM du cancer colorectal prend en compte :

- A) La taille de la tumeur.
- B) La différenciation histologique de la tumeur.
- C) L'âge du patient et la présence de comorbidités.
- D) La localisation de la tumeur dans le côlon.
- E) La présence de métastases ganglionnaires et à distance.

Q150. Cancers colorectaux

Une tumeur colique classée pT2 signifie que :

- A) La tumeur infiltre la sous séreuse.
- B) La tumeur infiltre la sous muqueuse.
- C) La tumeur infiltre la musculuse.
- D) La tumeur est intra-muqueuse.
- E) La tumeur infiltre le péritoine viscéral.

Q151. Tumeurs de la vessie

Quel facteur de risque est le plus fréquemment associé au développement du cancer de la vessie ?

- A) Antécédent de sondage vésical.
- B) Exposition professionnelle à l'amiante.
- C) Cystite chronique.
- D) Tabagisme chronique.
- E) Diabète de type 2.

Q152. Tumeurs de la vessie

Le cancer de la vessie peut se manifester par des symptômes cliniques. Lequel des suivants est le plus couramment observé ?

- A) Douleur abdominale intense.
- B) Hématurie.
- C) Ictère.
- D) Perte de poids rapide.
- E) Diarrhée chronique.

Q153. Cancers broncho-pulmonaires

Quel type histologique du cancer pulmonaire est le plus fréquemment observé chez les non-fumeurs ?

- A) Carcinome à petites cellules.
- B) Carcinome épidermoïde.
- C) Adénocarcinome.
- D) Carcinome à grandes cellules.
- E) Sarcome.

Q154. Cancers broncho-pulmonaires

Une prolifération tumorale carcinomateuse pulmonaire faite de cordons cellulaires avec ponts d'unions et quelques foyers de kératinisation correspond à :

- A) Un carcinome épidermoïde.
- B) Un adénocarcinome.
- C) Un carcinome à grandes cellules.
- D) Une tumeur carcinoïde.
- E) Un carcinome à petites cellules.

Q155. Cancers broncho-pulmonaires

Le type histologique correspondant à l'adénocarcinome exprime généralement les anticorps :

- A) TTF1.
- B) P63.
- C) Ck20.
- D) Chromogranine.
- E) P40.

Q156. Lymphome hodgkinien

Dans le cadre du lymphome de Hodgkin la cellule tumorale a souvent le phénotype suivant ?

- A) CD20-/CD15-/CD30-.
- B) CD20-/CD15+/CD30+.
- C) CD20+/CD15+/CD30+.
- D) CD20-/CD15-/CD30+.
- E) CD20-/CD15/CD30-.

Q157. Cancers broncho-pulmonaires

Dans le cadre de l'étude anatomopathologique, quel est l'intérêt de la technique de l'immunohistochimie dans le cancer pulmonaire ?

- A) Identifier les mutations génétiques.
- B) Déterminer l'indice de prolifération.
- C) Définir le type histologique.
- D) Evaluer la réponse au traitement.
- E) Prédire le pronostic.

Q158. Cancers colorectaux

Le grade histologique de la tumeur reflète le degré de différenciation tumorale. Quel énoncé est correct ?

- A) Un cancer colorectal bien différencié a un pronostic moins favorable qu'un cancer peu différencié.
- B) Un cancer colorectal peu différencié (anaplasique) a un pronostic plus favorable qu'un cancer bien différencié.
- C) Un cancer colorectal peu différencié a un pronostic moins favorable qu'un cancer bien différencié.
- D) Le grade histologique n'influence pas le pronostic du cancer colorectal.
- E) Le grade histologique fait partie de la classification TNM.

Q159. Lymphome hodgkinien

Le lymphome de Hodgkin est classé en plusieurs sous-types. Quel est le sous-type le plus fréquent de lymphome de Hodgkin ?

- A) Lymphome de Hodgkin riche en lymphocytes.
- B) Lymphome de Hodgkin riches en cellules tumorales.
- C) Lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire.
- D) Lymphome de Hodgkin scléro-nodulaire.
- E) Lymphome de Hodgkin à cellularité mixte.

Q160. Cancers colorectaux

Parmi les éléments suivants lesquels font partie des facteurs histopronostiques du cancer colorectal ?

- A) Type histologique.
- B) Age du malade.
- C) Comorbidités.
- D) Emboles vasculaires tumoraux.
- E) Expression par la tumeur de l'anticorps CDX2.

Q161. Adénites

Qu'est-ce qu'une adénite (ou lymphadénite) ?

- A) Une inflammation des ganglions lymphatiques.
- B) Une hypertrophie bénigne des ganglions lymphatiques.
- C) Une prolifération néoplasique des cellules ganglionnaires.
- D) Une obstruction lymphatique par des dépôts calciques.
- E) Une infection systémique affectant les ganglions lymphatiques.

Q162. Adénites

Quels examens permettent de localiser des adénopathies accessibles à la biopsie ?

- A) Imagerie.
- B) Biopsie-exérèse.
- C) Histologie.
- D) Sérologie infectieuse.
- E) Échographie Doppler.

Q163. Adénites

Quels germes sont responsables d'adénites suppurées ?

- A) Streptocoques.
- B) Staphylocoques.
- C) Bacillus subtilis.
- D) Escherichia coli.
- E) Pseudomonas aeruginosa.

Q164. Adénites

Quels agents infectieux causent une adénite granulomateuse ?

- A) Mycobacterium tuberculosis.
- B) Bartonella henselae.
- C) Histoplasma capsulatum.
- D) Virus de la grippe.
- E) Brucella spp.

Q165. Adénites

Quels diagnostics différentiels sont associés aux adénites granulomateuses ?

- A) Sarcoidose.
- B) Tuberculose.
- C) Maladie des griffes du chat.
- D) Lymphome.
- E) Histoplasmosis.

Q166. Adénites

Quels granulomes sont typiques de la sarcoïdose ?

- A) Granulomes non nécrosants.
- B) Granulomes caséux.
- C) Granulomes calcifiés.
- D) Granulomes suppurés.
- E) Granulomes épithélioïdes.

Q167. Lymphomes à petites cellules

Qu'est-ce qu'un lymphome ?

- A) Une prolifération maligne aux dépens des lymphocytes.
- B) Une hypertrophie bénigne des ganglions lymphatiques.
- C) Une inflammation des ganglions lymphatiques.
- D) Une prolifération des cellules épithéliales.
- E) Une anomalie fonctionnelle des plasmocytes.

Q168. Lymphomes à petites cellules

Quelle est la fréquence du lymphome folliculaire parmi les lymphomes non hodgkiniens ?

- A) 10 %.
- B) 25 %.
- C) 50 %.
- D) 75 %.
- E) 5 %.

Q169. Lymphomes à petites cellules

Quelle translocation est clé dans la lymphomagenèse du lymphome folliculaire ?

- A) t(14;18).
- B) t(9;22).
- C) t(11;14).
- D) t(8;14).

E) t(3;14).

Q170. Lymphomes a petites cellules

Quels sont les types de prélèvements utilisés pour le diagnostic d'un lymphome folliculaire ?

- A) Biopsie-exérèse ganglionnaire.
- B) Cytologie (aspiration ou apposition).
- C) Lavage broncho-alvéolaire.
- D) Prélèvement sanguin.
- E) Biopsie médullaire.

Q171. Lymphomes a petites cellules

Quels marqueurs du centre germinatif sont spécifiques au lymphome folliculaire ?

- A) CD10.
- B) Bcl-6.
- C) Cycline D1.
- D) Bcl-2.
- E) MUM1.

Q172. Lymphomes a petites cellules

Quels critères permettent de différencier une hyperplasie folliculaire d'un lymphome folliculaire ?

- A) Architecture ganglionnaire conservée.
- B) Follicules espacés et de tailles variables.
- C) Polarité des centres germinatifs conservée.
- D) Mitoses fréquentes.
- E) Absence d'expression de Bcl-2 dans les follicules normaux.

Q173. Gastrite

Quelles sont les deux grandes catégories de gastrites ?

- A) Gastrites infectieuses.
- B) Gastrites non infectieuses.
- C) Gastrites auto-immunes.
- D) Gastrites phlegmoneuse.
- E) Gastrites médicamenteuses.

Q174. Gastrite

Quels sont les rôles principaux du pathologiste dans l'étude des gastrites ?

- A) Diagnostic positif de gastrite.
- B) Classification de la gastrite à HP selon le système de Sydney.
- C) Recherche des complications de la gastrite.
- D) Traitement de la gastrite.
- E) Recherche d'infections associées à d'autres agents pathogènes.

Q175. Gastrite

Quels sont les facteurs de risque associés à l'infection à HP ?

- A) Bas niveau socio-économique.
- B) Contact proche avec des personnes infectées.
- C) Facteurs génétiques héréditaires.
- D) Pollution de l'eau potable.
- E) Consommation fréquente d'aliments crus ou mal cuits.

Q176. Gastrite

Comment HP résiste-t-il à l'acidité gastrique ?

- A) Grâce à l'effet tampon de l'urée.
- B) En augmentant la production de mucus gastrique.
- C) Par inactivation des cellules pariétales.
- D) En inhibant la sécrétion d'acide chlorhydrique.
- E) Par la formation de biofilms protecteurs.

Q177. Cancer de l'estomac

Quels sont les facteurs de risque environnementaux du cancer gastrique ?

- A) Aliments salés et séchés.
- B) Faible consommation de fruits et légumes.
- C) Tabagisme.
- D) Exposition au soleil.
- E) Consommation excessive d'alcool.

Q178. Cancer de l'estomac

Quels syndromes héréditaires sont associés à un risque accru de cancer gastrique ?

- A) Syndrome de Lynch.
- B) Syndrome de Peutz-Jeghers.
- C) Syndrome de polypose juvénile.
- D) Syndrome de Down.
- E) Syndrome de Li-Fraumeni.

Q179. Cancer de l'estomac

Quel est le type histologique le plus fréquemment observé dans les cancers gastriques précoces ?

- A) Type intestinal bien différencié.
- B) Type diffus peu différencié.
- C) Carcinome mucineux.
- D) Carcinome adéno-squameux.
- E) Carcinome indifférencié.

Q180. Cancer de l'estomac

Quels facteurs influencent le pronostic de l'adénocarcinome gastrique ?

- A) Stade TNM.
- B) Différenciation tumorale.
- C) Présence d'embolies vasculaires.
- D) Type histologique.
- E) Expression des récepteurs HER2.

Q181. MICI

Sur une pièce opératoire d'iléon réséquée à cause d'une maladie de Crohn grave :

- A) L'inflammation n'est retrouvée que sur la muqueuse.
- B) Les lésions sont segmentaires.
- C) Une sténose luminale rend le diagnostic peu probable.
- D) La présence de granulomes épithélio-gigantocellulaires est typique et constante.
- E) On peut observer des fissures profondes.

Q182. MICI

Les biopsies endoscopiques du tube digestif réalisées en cas de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI):

- A) Doivent être multiples et étagées.
- B) Renseignent sur l'étendue des lésions en profondeur (atteinte de la muqueuse, la sous muqueuse et la musculature).
- C) Sont adaptées au diagnostic des MICI.
- D) Peuvent servir à des analyses moléculaires.
- E) Permettent de détecter des agents infectieux comme le cytomégalovirus.

Q183. MICI

Sur une pièce opératoire de rectum réséqué, quelles lésions sont plus en faveur d'une RCH active que d'une maladie de Crohn ?

- A) L'inflammation n'est retrouvée que dans la muqueuse.
- B) Les lésions sont segmentaires, avec des intervalles sains.
- C) Les ulcérations et les saignements intra-muqueux sont marqués.
- D) Quelques granulomes épithélio-giganto-cellulaires sont observés.
- E) De nombreux micro-abcès cryptiques sont visibles.

Q184. Polype et polypose

A propos de la séquence polype-cancer dans le côlon :

- A) Les polypes villosités dégénèrent plus souvent que les polypes tubuleux.
- B) Les degrés de dysplasie s'évaluent en 4 grades.
- C) Les polypes adénomateux sont le plus sujet à dégénérer.
- D) Tout polype colique découvert doit faire proposer une consultation en génétique.
- E) Un foyer de cancer sur polype, infiltrant la sous-muqueuse, correspond à un carcinome intra-muqueux classé pT2.

Q185. Polype et polypose

L'analyse anatomo-pathologique d'un polype colique :

- A) Rassure en cas de polype juvénile, car leur risque de dégénérescence est très faible.
- B) Indique un état précancéreux, s'il s'agit d'un adénome colique.
- C) Doit déterminer le degré de la métaplasie, en cas d'adénome.
- D) Doit décrire l'état des marges d'exérèse, en cas d'adénome.
- E) Doit indiquer le niveau d'infiltration et l'aspect du pied, en cas d'un polype pédiculé cancérisé.

Q186. Polype et polypose

On distingue parmi les polypes simples non épithéliaux les :

- A) Polype de Peutz-Jeghers.
- B) Polype inflammatoire.
- C) Adénome plan.
- D) Polype hyperplasique.
- E) Adénome festonné traditionnel.

Q187. Cancer de prostate

Quel(s) est (sont) le(s) paramètre(s) à prendre en compte pour le dépistage du cancer de prostate ?

- A) Le TR.
- B) Le PSA.
- C) L'IRM de prostate.
- D) L'échographie de prostate.
- E) L'âge du malade.

Q188. Cancer de prostate

Définir le score de Gleason :

- A) Est un score histo-pronostique caractérisant le degré de différenciation de la tumeur.
- B) est un facteur pronostic essentiel dans la prise en charge du cancer de prostate.
- C) est obtenu en additionnant les 2 grades histologiques le plus représenté et le plus agressif dans la tumeur.
- D) Sur biopsie, un contingent de grade 5 minoritaire (moins de 5% du volume total) par rapport aux contingents de grade 3 et 4, doit être mentionné sous forme d'un grade tertiaire.
- E) Scores de 8 à 10 correspondent aux cancers de prostate peu différenciés et de mauvais pronostic.

Q189. Cancer de prostate

Les critères diagnostiques histologiques majeurs de l'adénocarcinome acinaire conventionnel sont :

- A) Mitoses atypiques et nombreuses.
- B) Augmentation de la taille du noyau.
- C) Désorganisation architecturale.
- D) Nucléole proéminent.
- E) Atypies cytonucléaires.

Q190. Cancer du col de l'utérus

Le frottis cervico-utérin :

- A) doit intéresser l'exocol et la zone de jonction.
- B) est coloré par le HARISS SHORR.
- C) est classé selon la classification de Papanicolaou.
- D) à pour but de dépister les lésions précancéreuses du col utérin.
- E) est classé selon le système Bethesda.

Q191. Cancer du col de l'utérus

Le carcinome in situ du col utérin se caractérise par :

- A) L'intégrité de la membrane basale.
- B) Une désorganisation architecturale de tout l'épithélium.
- C) La présence de cellules néoplasiques en file indienne dans le chorion papillaire.
- D) Des anomalies cytoplasmiques et mitoses anormales.
- E) Le développement d'un stroma inflammatoire.

Q192. Cancer du col de l'utérus

La classification de Bethesda 2014 :

- A) Est recommandée pour un FCV à visée hormonale.
- B) Est recommandée pour les frottis de dépistage.
- C) Utilise le terme de lésion intra-épithéliales de bas grade et de haut grade.
- D) L'âge à partir duquel la présence de cellules endométriales doit s'accompagner d'une biopsie de l'endomètre, est passé à 50 ans au lieu de 40 ans.
- E) Inclut les lésions virales à HPV dans les lésions de bas grade.

Q193. Cancer du col de l'utérus

Le carcinome épidermoïde HPV-associé du col utérin :

- A) Est le plus fréquent.
- B) Est l'apanage de la femme âgée.
- C) survient le plus souvent à partir d'une lésion précancéreuse.
- D) est en rapport avec l'HPV de type 16 et 18.
- E) L'étude immunohistochimique montre une négativité de la p16.

Q194. Cancer de l'endomètre

Parmi les facteurs du risque de cancer de l'endomètre, on peut noter :

- A) L'obésité.
- B) Les grossesses multiples.
- C) Syndrome de Lynch.
- D) L'allaitement.
- E) Le traitement oestrogénique prolongé.

Q195. Cancer de l'endomètre

Les informations que doit contenir un compte-rendu anatomopathologique d'une pièce d'hystérectomie pour carcinome endométrial :

- A) Le type histologique.
- B) Emboles vasculaire et lymphatique.
- C) Le grade selon FIGO.
- D) Extension au col, paramètres, annexes et autre organe pelvien.
- E) La profondeur d'invasion de l'endomètre.

Q196. Cancer de l'endomètre

Selon la classification moléculaire actuelle des cancers de l'endomètre :

- A) Trois types moléculaires sont reconnus.
- B) Le type ultra-muté (POLE mutée) se caractérise par une charge mutationnelle très élevée et un bon pronostic.
- C) Les carcinomes endométriaux p53 muté, en l'absence de mutation POLE, ont le pronostic le plus fâcheux, comparés aux autres types moléculaires.
- D) Une désescalade thérapeutique pour les carcinomes d'endomètre POLE muté est possible.
- E) La recherche d'une instabilité micro-satellitaire est possible grâce à l'étude immunohistochimique.

Q197. Cancer de l'endomètre

La biopsie de l'endomètre :

- A) Est indiquée pour déterminer l'étiologie d'une métrorragie.
- B) Permet de dépister les lésions précancéreuses de l'endomètre.
- C) peut être réalisée à n'importe quelle période du cycle.
- D) Confirme le diagnostic d'une néoplasie.
- E) Peut-être réalisée pour évaluer l'extension tumorale au myomètre.

Q198. Cancer de l'endomètre

Parmi les tumeurs du revêtement épithélial de surface de l'ovaire on cite :

- A) Les tumeurs mucineuses.
- B) Les tumeurs de granulosa.
- C) Les tératomes.
- D) Les tumeurs à cellules claires.
- E) Les tumeurs des cordons sexuels.

Q199. Cancer de l'endomètre

Les tumeurs épithéliales malignes de l'ovaire :

- A) Sont dominées par les carcinomes mucineux.
- B) Le carcinome séreux de bas grade se caractérise par une mutation de la p53.
- C) Les carcinomes séreux sont gradés selon le grading de Malpika.
- D) Un carcinome séreux de haut grade est souvent associé à des foyers de tumeur séreuse borderline.
- E) Les carcinomes séreux ovariens présentent le profil immunohistochimique suivant : CK7+, CK20-, PAX8+, WT1+.

Q200. Cancer de l'endomètre

Sur le plan microscopique, le cystadénocarcinome séreux de l'ovaire, est caractérisé par :

- A) Une architecture glandulaire, papillaire ou solide.
- B) Atypies cytonucléaires faibles à marquées.
- C) Mitoses souvent très nombreuses.
- D) Non invasion du stroma.
- E) Présence toujours de psammomes.

Q201. Cancers colorectaux

Quelle(s) est (sont) la (les) lésion(s) précancéreuse(s) la (les) plus fréquente(s) du cancer colorectal ?

- A) Polype hyperplasique.
- B) Adénome tubuleux.
- C) Adénome villosus.
- D) Colite ulcéreuse.
- E) Polype inflammatoire.

Q202. Cancers colorectaux

Parmi les types histologiques suivants, lequel est le plus fréquent dans le cancer colorectal ?

- A) Adénocarcinome.
- B) Carcinome épidermoïde.
- C) Lymphome.
- D) Sarcome.
- E) Tumeur neuroendocrine.

Q203. Cancers broncho-pulmonaires

Une des propositions suivantes ne fait pas partie des facteurs histopronostiques du cancer pulmonaire :

- A) Type histologique.
- B) Métastases ganglionnaires.
- C) Embolies vasculaires tumorales.
- D) Taille tumorale.
- E) Présence d'infiltrat lymphocytaire intra-tumoral.

Q204. Cancers broncho-pulmonaires

Parmi les facteurs histopronostiques suivants, lequel (lesquels) ne fait (font) pas partie de la stadification pTNM ?

- A) Présence d'adénopathies métastatiques.
- B) Taille de la tumeur.
- C) Sous-type histologique.
- D) Présence des métastases viscérales.
- E) Atteinte des marges chirurgicales.

Q205. Tumeurs de la vessie

Dans la classification TNM du cancer colorectal, que signifie pT3 ?

- A) La tumeur infiltre la sous-muqueuse.
- B) La tumeur infiltre la musculuse.
- C) La tumeur infiltre la sous-séreuse.
- D) La tumeur infiltre les organes voisins.
- E) La tumeur infiltre le péritoine viscéral.

Q206. Cancers broncho-pulmonaires

Parmi les propositions suivantes, lequel de ces types histologiques est plus fréquent au niveau du poumon ?

- A) Sarcome.
- B) Lymphome.
- C) Mélanome.
- D) Carcinome épidermoïde.
- E) Carcinome neuroendocrine.

Q207. Cancers broncho-pulmonaires

Parmi les facteurs de risque suivants, lequel est le plus fortement associé au carcinome épidermoïde pulmonaire ?

- A) Tabac.
- B) Exposition à l'amiante.
- C) Pollution de l'air.
- D) Facteurs génétiques.
- E) Exposition au radon.

Q208. Cancers broncho-pulmonaires

Quelle (s) mutation (s) est (sont) fréquemment retrouvée (s) dans les adénocarcinomes pulmonaires ?

- A) Mutation EGFR.
- B) Mutation KRAS.
- C) Réarrangement ALK.
- D) Instabilité des microsatellites (MSI).
- E) Toutes les réponses ci-dessus.

Q209. Cancers broncho-pulmonaires

Quel type histologique est caractérisé par une prolifération tumorale glandulaire de taille et de forme variables ?

- A) Carcinome épidermoïde.
- B) Carcinome à petites cellules.
- C) Adénocarcinome.
- D) Tumeur carcinoïde.
- E) Lymphome malin.

Q210. Cancers broncho-pulmonaires

Quel(s) marqueur(s) immunohistochimique(s) est (sont) utilisé(s) pour différencier un carcinome épidermoïde d'un adénocarcinome pulmonaire ?

- A) TTF-1.
- B) P63.
- C) Chromogranine A.
- D) GATA3.
- E) Synaptophysine.

Q211. Cancers broncho-pulmonaires

Le carcinome épidermoïde pulmonaire est typiquement associé à :

- A) Une croissance périphérique avec envahissement des plèvres.
- B) Une localisation centrale et une nécrose fréquente.
- C) Une prolifération neuroendocrine.
- D) Des mutations EGFR.
- E) Une production abondante de mucus.

Q212. Lymphome hodgkinien

Quelle est la cellule caractéristique du lymphome de Hodgkin classique ?

- A) Cellule de Langhans.
- B) Cellule de Reed-Sternberg.
- C) Cellule Pop-Corn.
- D) Cellule dendritique.
- E) Cellule de Muller.

Q213. Lymphome hodgkinien

Quel(s) marqueur(s) immunohistochimique(s) est (sont) positif(s) dans les cellules caractéristiques du lymphome de Hodgkin ?

- A) CD20.
- B) CD30.
- C) CD3.
- D) CD56.
- E) CD15.

Q214. Lymphome hodgkinien

Quel est le rôle principal de l'examen anatomopathologique dans le lymphome de Hodgkin ?

- A) Confirmer le diagnostic et sous-typé la maladie.
- B) Identifier les métastases à distance.
- C) Déterminer la sensibilité aux traitements.
- D) Stadifier la maladie.
- E) Prédire une résistance aux thérapeutiques.

Q215. Tumeurs de la vessie

Quel est le type histologique le plus fréquent du cancer de la vessie ?

- A) Carcinome urothélial.
- B) Carcinome épidermoïde.
- C) Adénocarcinome.
- D) Sarcome.
- E) Carcinome neuroendocrine.

Q216. Lymphome hodgkinien

Quel sous-type histologique du lymphome de Hodgkin est le plus fréquent ?

- A) Scléro-nodulaire.
- B) Cellularité mixte.
- C) Riche en lymphocytes.
- D) Riche en cellules tumorales.
- E) Nodulaire à prédominance lymphocytaire / Poppema Lennert.

Q217. Tumeurs de la vessie

Quel marqueur immunohistochimique est fréquemment utilisé pour confirmer un carcinome urothélial ?

- A) GATA3.
- B) CD30.
- C) HER2.
- D) CD3.
- E) P63.

Q218. Tumeurs de la vessie

Quel sous-type de carcinome de la vessie est le plus souvent associé à une bilharziose (schistosomiase) ?

- A) Carcinome urothélial.
- B) Carcinome épidermoïde.
- C) Adénocarcinome.
- D) Lymphome.
- E) Sarcome.

Q219. Tumeurs de la vessie

Une tumeur vésicale stade pTa correspond à :

- A) Une tumeur confinée à la muqueuse sans invasion.
- B) Une tumeur infiltrant la musculuse.
- C) Une tumeur infiltrant la sous-séreuse.
- D) Une tumeur avec métastases ganglionnaires.
- E) Une tumeur envahissant la lamina propria.

Q220. Lymphome hodgkinien

Dans quel sous-type histologique du lymphome de Hodgkin classique observe-t-on souvent un épaissement de la capsule ganglionnaire avec présence des bandes de collagène délimitant des nodules ?

- A) Cellularité mixte.
- B) Riche en lymphocytes.
- C) Pauvre en lymphocytes.
- D) Scléro-nodulaire.
- E) Sous-type nodulaire avec prédominance lymphocytaire.

OCTOBRE 2024

Q221. Adénites

Adénite suppurée : Causes courantes, caractéristiques morphologiques microscopiques de l'adénite suppurée, et colorations pouvant orienter vers l'agent causal.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q222. Gastrite

Décrire les critères de la classification de Sydney de la gastrite chronique à Helicobacter pylori.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q223. Cancers broncho-pulmonaires

Décrire la prise en charge macroscopique d'une pièce de lobectomie pulmonaire.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q224. Cancer de l'endomètre

Le carcinome séreux de haut grade de l'ovaire : Caractéristiques histologiques et immunohistochimiques.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q225. Adénites

CAS CLINIQUE : Une femme de 32 ans consulte pour une douleur et un gonflement dans la région axillaire droite apparus depuis 5 jours. À l'examen physique, il existe une masse palpable, chaude et fluctuante. La patiente signale également une fièvre légère et une sensation de malaise général. Une échographie est réalisée et révèle une adénopathie qui renferme une collection liquidienne compatible avec un abcès. Une biopsie exérèse du ganglion axillaire est pratiquée, suivie d'un examen histopathologique. L'examen anatomopathologique révèle une adénite suppurée. Question : Qu'est-ce que l'adénite suppurée et quelles en sont les causes courantes ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q226. Adénites

Décrivez les caractéristiques morphologiques microscopiques de l'adénite suppurée.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q227. Adénites

Quelles autres colorations peuvent orienter vers l'agent causal ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q228. Gastrite

Décrire les critères de la classification de Sydney de la gastrite chronique à Helicobacter pylori.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q229. Cancers broncho-pulmonaires

CAS CLINIQUE : Monsieur R.B âgé de 65ans, tabagique chronique consulte pour des douleurs thoraciques chroniques et une notion de toux chronique avec une hémoptysie récente. Un scanner thoracique a montré la présence d'une masse tumorale pulmonaire lobaire droite périphérique mesurant 45x20mm. Une biopsie scanoguidée montre une prolifération tumorale carcinomateuse peu différenciée remaniée par des foyers de nécrose et de suffusions hémorragiques. L'immunohistochimie montre une positivité intense et diffuse des cellules par les anticorps TTF1 et CK7 et une absence d'expression de l'anticorps P63. Question : Donner le type histologique de cette prolifération tumorale.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q230. Cancers broncho-pulmonaires

Citer les différents aspects macroscopiques de ce type de tumeur (adénocarcinome pulmonaire).

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q231. Cancers broncho-pulmonaires

Citer le testing moléculaire minimum à demander chez ce patient en vue d'envisager une éventuelle thérapie ciblée.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q232. Cancers broncho-pulmonaires

Décrire la prise en charge macroscopique d'une pièce de lobectomie pulmonaire.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q233. Cancers colorectaux

Quels sont les facteurs pronostiques du cancer colorectal ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q234. MICI

Citez 2 caractères histologiques communs des maladies chroniques idiopathiques de l'intestin (MICI).

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q235. MICI

En cas d'évolution aigue grave ou inhabituelle d'une MICI, quelle est la complication qu'il faut rechercher ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q236. Cancer du col de l'utérus

Que doit intéresser le prélèvement pour un frottis cervico-utérin (FCU) satisfaisant ? Quel est le système adopté pour son interprétation ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q237. Cancer du col de l'utérus

- Le dépistage du cancer du col utérin a pour but de :
- A) Donner un diagnostic exact d'un cancer du col.
 - B) Détecter un cancer du col à un stade précoce.
 - C) Détecter une lésion dysplasique.
 - D) Sélectionner des femmes à haut risque du cancer du col.

Q238. Cancer de l'endomètre

Quelles sont les caractéristiques histologiques et immunohistochimiques d'un carcinome séreux de haut grade de l'ovaire ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q239. Cancer de l'endomètre

Citez les 4 types moléculaires de carcinomes endométriaux.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q240. Cancer de prostate

Quel est le système de grading adopté pour scorer les adénocarcinomes prostatiques ? Citez 2 autres facteurs histopronostiques qui doivent figurer dans son compte-rendu final sur pièce de prostatectomie.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

NORMALE 2023

Q241. Polype et polypose

CAS CLINIQUE 1 : Mr X, âgé de 52ans, a bénéficié d'une coloscopie indiquée pour douleurs abdominales et rectorragies de faible abondance. La coloscopie a révélé un polype pédiculé de 2 cm rectal. La tête du polype était ulcérée. Une polypectomie a été réalisée et le spécimen était adressé au laboratoire d'anatomie pathologique. Quels sont les étapes de la prise en charge macroscopique d'un spécimen de polypectomie ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q242. Polype et polypose

Dans le cadre du CAS CLINIQUE 1 (polype rectal de 2 cm), la présence d'ulcération oriente vers quelle éventualité ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q243. Polype et polypose

Le compte rendu anatomo-pathologique rapporte un (adénome tubulo-villeux), en (dysplasie de haut grade), (cancérisé), (classé 3 selon la classification de Haggit). Expliquer la signification de ces 4 éléments.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q244. Cancers colorectaux

Décrire les voies moléculaires impliquées dans la transformation cancéreuse d'un adénome colique (Séquence adénome-carcinome).

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q245. MICI

Expliquer les éléments distinctifs anatomopathologiques macroscopiques et microscopiques entre la maladie de Crohn et la recto-colite hémorragique.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q246. Tumeurs du rein

CAS CLINIQUE 2 : Monsieur M.B âgé de 57ans, tabagique chronique consulte pour des douleurs lombaires chroniques et une notion d'hématurie totale d'apparition récente. Quel(s) sont les examen(s) para-cliniques à demander ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q247. Tumeurs du rein

Un des examens demandés a montré la présence d'une masse rénale de 45x40mm polaire supérieure droite, séparée par un liseré graisseux de la glande surrénale. La conduite à tenir était de réaliser une néphrectomie élargie. Décrire les étapes de la prise en charge macroscopique d'une pièce de néphrectomie élargie.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q248. Tumeurs du rein

Voici une partie de l'étude microscopique du compte rendu anatomopathologique de la pièce de néphrectomie élargie : on observe un parenchyme rénal infiltré par une prolifération tumorale carcinomateuse à cellules claires. Les cellules tumorales sont pourvues d'un noyau rond ou ovalaire, muni d'un petit nucléole visible au fort grossissement (x400) et à peine visible au faible grossissement. Donner, selon cette description morphologique, le grade nucléolaire de OMS- ISUP ?

- A) Je comprends.

B) Je ne comprends pas?

Q249. Tumeurs du rein

Citez les éléments qui doivent figurer sur le compte rendu anatomopathologique d'une pièce de néphrectomie.

A) Je comprends.

B) Je ne comprends pas?

Q250. Tumeurs du rein

L'évolution a été marquée par une fracture pathologique du col du fémur montrant une infiltration carcinomateuse indifférenciée. Citez deux anticorps utiles pour rattacher l'origine rénale à cette localisation secondaire.

A) Je comprends.

B) Je ne comprends pas?

Q251. Cancers colorectaux

Quel sont les facteurs pronostiques du cancer colo-rectal ?

A) Je comprends.

B) Je ne comprends pas?

Q252. Cancer du sein

Vous recevez une patiente de 45 ans, avec une tumeur du sein. Une biopsie montre un carcinome mammaire NOS : quels sont les facteurs histopronostiques qui doivent figurer dans ce compte rendu anapath ?

A) Je comprends.

B) Je ne comprends pas?

NORMALE 2022

Q253. Gastrite

Vous recevez ce compte rendu anapath d'une biopsie gastrique : On a reçu 5 fragments mesurant entre 0,4 et 0,6 cm, inclus en totalité dans 1 bloc. Histologiquement, il s'agit sur 3 fragments d'une muqueuse de type antral et sur deux fragments d'une muqueuse de type fundique. L'épithélium de surface est de type calcipare, cryptique régulier. Les glandes sont bien différenciées présentant une atrophie modérée au niveau antrale, avec une diminution du contingent des cellules pariétales au niveau fundique. Le chorion est le siège d'un infiltrat inflammatoire modéré fait de lymphocytes réalisant trois follicules lymphoïdes au niveau antrale, de plasmocytes et de nombreux polynucléaires neutrophiles. Au niveau des cryptes, on note la présence de bâtonnets d'HP ++. Quelle est la conclusion de ce compte rendu anapath ?

A) Je comprends.

B) Je ne comprends pas.

Q254. Gastrite

Quel système est utilisé pour classer les gastrites ?

A) Je comprends.

B) Je ne comprends pas.

Q255. Gastrite

Quelle(s) est (sont) les complications liée(s) à cette gastrite ? Expliquez.

A) Je comprends.

B) Je ne comprends pas.

Q256. Gastrite

Nommez les gastrites microscopiques.

A) Je comprends.

B) Je ne comprends pas.

Q257. Cancer du sein

Madame X âgée de 39 ans, vient vous voir pour un nodule du sein gauche de 1 cm non douloureux et fixe à la palpation, avec à l'examen une adénopathie axillaire homolatérale : Quelle est votre hypothèse diagnostic et pourquoi ? Que pouvez-vous demander comme examen (s) pour confirmer votre diagnostic ?

A) Je comprends.

B) Je ne comprends pas.

Q258. Cancer du sein

L'examen anapath de cette lésion a conclu à un carcinome mammaire NOS, HER2+ : Quelles sont les facteurs histopronostique obligatoires qui doivent figurer sur ce compte rendu ?

A) Je comprends.

B) Je ne comprends pas.

Q259. Cancer du sein

Expliquez l'HER2 ?

A) Je comprends.

B) Je ne comprends pas.

Q260. Cancer du sein

Que veut dire une tumeur du sein HER2+ ? que pouvez-vous proposer à cette patiente comme traitement au vu de ce résultat ?

A) Je comprends.

B) Je ne comprends pas.

Q261. Anatomie pathologique spéciale II

Vous recevez un jeune garçon de 12 ans qui se plaint de douleur du genou droit depuis quelques semaines qui ne cède pas sous antalgique habituel. A ce stade quel examen allez-vous demander impérativement chez ce patient ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q262. Anatomie pathologique spéciale II

Une étude anapath a été réalisée chez ce patient et parle de cellules ostéoblastiques atypiques qui produisent de l'ostéoïde tumorale ou de la matrice osseuse tumorale. A quel diagnostic correspond cette description anapath ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q263. Anatomie pathologique spéciale II

que proposez-vous à ce patient comme stratégie thérapeutique ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q264. Anatomie pathologique spéciale II

Après traitement, l'anapath reçoit la pièce opératoire : décrire brièvement le protocole de prise en charge.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q265. Anatomie pathologique spéciale II

Nommez le score utilisé pour déterminer la qualité de la réponse au traitement ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q266. Cancers broncho-pulmonaires

Vous avez en consultation une patiente de 50 ans, avec un nodule pulmonaire périphérique sous pleurale à l'imagerie. Une biopsie scano-guidée a été réalisée, le compte rendu anatomopathologique parle d'un adénocarcinome moyennement différencié : Quel le profil immunohistochimique de l'adénocarcinome pulmonaire primitif ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q267. Cancers broncho-pulmonaires

Quels sont les tests moléculaires que vous allez demander chez cette patiente ? pourquoi ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

2022

Q268. Polype et polypose

Renseignements cliniques : homme de 71 ans, épigastalgies chroniques et RGO chronique depuis 30 ans. Suivi pour des hémorroïdes depuis 20 ans avec constipation et rectorragies. Coloscopie : deux polypes sessiles au niveau du colon droit transverse / polype au niveau du colon gauche. FOGD : fundite congestive / antrite érythémateuse / bulbe ulcérateur. Compte rendu de la BIOPSIE : On a reçu 6 fragments de 0.2 à 0.4 cm, inclus en totalité dans un bloc. Histologiquement, il s'agit d'une muqueuse colique siège d'une prolifération faite de glandes et de villosité, bordées par un épithélium cylindrique, pseudostratifié par endroit, sans perte de la mucosécrétion. Les noyaux sont hyperchromatiques, siège d'atypies cytonucléaires modérées, avec quelques figures de mitoses ne dépassant pas les 1/2 de la hauteur épithéliale. Le chorion est le siège d'un infiltrat inflammatoire modéré essentiellement mononucléé. CONCLUSION : Aspect histologique d'un (A).....(B). 1- Que pensez-vous de la qualité du prélèvement ? 2- Complétez la conclusion avec les items A et B. 3- Donnez sous forme de tableau la classification des dysplasies digestives utilisée. 4- Donnez la définition d'un polype cancérisé. 5- Quels sont les données minimales qui doivent figurer sur le compte rendu pour un adénome cancérisé ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q269. Cancer de prostate

Vous recevez un patient âgé de 67 ans, qui se plaint de dysurie. Il vient avec un compte rendu anatomo-pathologique de biopsies prostatiques (Image jointe montrant des structures glandulaires fusionnées et cribriformes). 1- Quelles sont les règles à respecter dans la réalisation des biopsies prostatiques ? 2- Donnez le score de Gleason ? expliquez. 3- Nommez le protocole utilisé en macroscopie pour la pièce de prostatectomie radicale ? 4- Quels sont les facteurs pronostics qui doivent figurer sur le compte rendu anatomo-pathologique ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q270. Cancer du col de l'utérus

Donnez la classification de Bethesda qui permet d'interpréter les frottis cervicaux vaginaux.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q271. Tumeurs du rein

Donnez les types histologiques les plus fréquents des tumeurs du rein de l'adulte.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

RATTRAPAGE 2021

Q272. MICI

Patient de 25 ans suivi pour spondyloarthrite (SPA) sous traitement depuis 2 ans et qui présente depuis quelques mois des troubles du transit avec alternance de diarrhée et de constipation. Le patient consulte pour une aggravation de sa symptomatologie avec apparition d'émissions glairo-sanglantes. Questions : A- Quel(s) est votre hypothèse diagnostic concernant cette symptomatologie digestive ? B- Quel est l'examen utile à demander chez ce patient ? C- Les examens radiologiques montrent un épaississement au niveau iléo-cécale, des biopsies sont faites et montrent 'une colite subaiguë avec présence de granulome épithélioïde'. Ce résultat réconforte votre hypothèse diagnostic ? pourquoi ? D- Quel est le (ou les) diagnostic différentiel ? E- Mettez sous forme de tableau les différentes caractéristiques qui permettent de différencier entre ces diagnostics évoqués.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q273. Polype et polypose

Donnez sous forme de tableaux les différentes caractéristiques des polypes simples épithéliaux.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q274. Cancer du sein

Cas clinique 2 : Il s'agit d'une patiente âgée de 35 ans, nullipare, ayant une mère traitée pour un cancer du sein, et qui présente un nodule du sein gauche avec un aspect en peau d'orange. Questions : 1. Quels sont les facteurs de risque chez cette patiente ? 2. Quel est le bilan à lui demander ? 3. La biopsie du sein révèle un carcinome infiltrant de type non spécifique (ancien carcinome canalaire infiltrant). a. Quels sont les critères histologiques qu'il faut décrire dans le compte rendu ? b. Quels sont les marqueurs immunohistochimiques obligatoires à demander ? c. Sur le plan moléculaire, la patiente a un carcinome infiltrant de type luminal A. Expliquez de quoi il s'agit, quel est son pronostic et quelles sont les possibilités thérapeutiques.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

NORMALE 2021

Q275. Polype et polypose

Vous recevez ce compte rendu anatomopathologique d'une polypectomie colique : On a reçu un polype pédiculé mesurant 3.5x2.5x3 cm, inclus en totalité dans 5 blocs. Histologiquement, il s'agit d'une muqueuse colique siège d'une prolifération faite de glandes et de villosités bordées par un épithélium cylindrique cylindrique, pseudostratifié, avec une perte de la mucosécrétion de façon diffuse. Les noyaux sont hyperchromatiques, siège d'importantes atypies cytonucléaires, avec des figures de mitoses qui siègent sur toute la hauteur épithéliale. Le chorion est le siège d'un infiltrat inflammatoire modéré essentiellement mononucléé. Absence de foyer infiltrant. Résection complète. 1- Complétez les items A (Description microscopique) et B (Conclusion). 2- Donnez les autres types de polypes avec risque de dégénérescence.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q276. Cancer du col de l'utérus

Madame X âgée de 39 ans qui vient vous voir car le résultat de son FCV l'inquiète, il indique « LSIL ». 1- Que veut dire ce résultat ? Quels sont les signes cytologiques de cette lésion ? 2- Quelle est l'origine de cette lésion ? 3- Quels sont les autres facteurs de risque à rechercher chez cette dame ? 4- Que pourriez-vous proposer à cette dame ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q277. Cancer de prostate

Vous recevez un patient âgé de 67 ans, qui se plaint de dysurie. Il vient avec un compte rendu anatomo-pathologique de biopsies prostatiques qui montre une image au microscope avec des massifs cribriformes. 1- Quelles sont les règles à respecter dans la réalisation des biopsies prostatiques ? 2- Donnez le score de Gleason ? 3- Est-ce qu'un score de gleason 3+4 est équivalent à un score de 4+3 ? Expliquez. 4- Nommez le protocole utilisé en macroscopie pour la pièce de prostatectomie radicale ? 5- Quels sont les facteurs pronostics qui doivent figurer sur le compte rendu anatomo-pathologique ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q278. Cancers broncho-pulmonaires

Vous avez en consultation une patiente de 50 ans, avec un nodule pulmonaire périphérique sous pleurale à l'imagerie. Une biopsie scano-guidée a été réalisée, le compte rendu anatomopathologique parle d'un adénocarcinome moyennement différencié : 1- Quel le profil immunohistochimique de l'adénocarcinome pulmonaire primitif ? 2- Quels sont les tests moléculaires que vous allez demander chez cette patiente ? Pourquoi ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

RATTRAPAGE 2020

Q279. Polype et polyposé

Vous recevez un patient de 37 ans, avec un syndrome dyspeptique et une diarrhée. Une colposcopie a été faite et montre un polype qui a été réséqué. Le compte rendu anatomopathologique montre : Reçu 1 fragment de 1 cm, inclus en totalité dans un bloc. Histologiquement, il s'agit d'une muqueuse colique siège d'une prolifération faite de villosités et de glandes bordées par un épithélium cylindrique, pseudostratifié par endroit, sans perte de la mucosécrétion. Les noyaux sont hyperchromatiques, siège d'atypies cytonucléaires modérées, avec quelques figures de mitoses ne dépassant pas les 1/2 de la hauteur épithéliale. Le chorion est le siège d'un infiltrat inflammatoire modéré essentiellement mononucléé. est saine.

- 1- Donnez le type de polype ?
- 2- Remplissez l'espace par l'item manquant ?
- 3- Donnez le type de dysplasie ?
- 4- Donnez la définition d'un polype cancérisé ? Quels sont les critères qui prédisent de la transformation maligne d'un polype ?
 - A) Je comprends.
 - B) Je ne comprends pas.

Q280. Cancers colorectaux

Patient de 50 ans qui se présente avec un syndrome occlusif, une coloscopie avec biopsie a été faite et montre une tumeur sigmoïdienne bourgeonnante, une iléostomie a été réalisée. La biopsie de la tumeur a montré un adénocarcinome infiltrant moyennement différencié :

- 1- Donnez les facteurs histopronostiques classiques pour le cancer du colon ?
- 2- Nommez les trois principales voies de la carcinogenèse colorectale ?
- 3- Expliquez par un algorithme comment détecter le syndrome de Lynch ?
 - A) Je comprends.
 - B) Je ne comprends pas.

Q281. Cancer de prostate

Cancer de la prostate :

- 1- Nommez le système utilisé pour scorer histologiquement le cancer de la prostate ?
- 2- Les deux photos suivantes représentent le même champ tumoral à différents grossissements : donner le score ? expliquez ?
 - A) Je comprends.
 - B) Je ne comprends pas.

Q282. Cancer du col de l'utérus

Donnez sous forme de tableau la Classification de Bethesda du cancer du col utérin.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

NORMALE 2020

Q283. Gastrite

Vous recevez un patient de 37 ans, avec un syndrome dyspeptique, qui a un compte rendu anatomopathologique d'une biopsie gastrique comme suit : Reçu 2 fragments de 0.2 à 0.4cm, inclus en totalité dans un bloc. Histologiquement, il s'agit d'une muqueuse antrale siège de lésion de gastrite légère, d'atrophie légère. HP ++. Absence de métaplasie intestinale ou de dysplasie. 1- Donnez le nom du système utilisé pour classer cette gastrite ? 2- Donnez les items manquants au niveau des espaces vides du compte rendu ? 3- Que pensez-vous du nombre de biopsies ? 4- Donnez les 2 complications majeures de cette gastrite ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q284. Cancers colorectaux

Patient de 50 ans qui se présente avec un syndrome occlusif, une coloscopie avec biopsie a été faite et montre une tumeur sigmoïdienne bourgeonnante, une iléostomie a été réalisée. La biopsie de la tumeur a montré un adénocarcinome infiltrant moyennement différencié : 1- Donnez les facteurs histopronostiques classiques pour le cancer du colon. 2- Nommez les trois principales voies de la carcinogenèse colorectale. Une colectomie a été réalisée chez ce patient et montre un adénocarcinome moyennement différencié de 4.5 cm qui infiltre la graisse péri-colique avec un stroma lymphoïde dense. 3- Quel syndrome suspectez-vous chez ce patient ? 4- Donnez le ou les méthodes pour le confirmer ? expliquez au moins une des méthodes. Une étude immunohistochimique sur cette tumeur a été faite et montre : Tissu sain : MLH1 : exprimé, PMS2 : exprimé, MSH2 et MSH6 : exprimés. Tissu tumoral : MLH1 : exprimé, MSH2 : non exprimé, PSM2 : exprimé, MSH6 ; exprimé. 5- Quelle est votre conclusion ? 6- Quelles sont les conséquences de votre conclusion ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q285. Cancer de prostate

Cancer de la prostate : 1-nommez le système utilisé pour scorer histologiquement le cancer de la prostate ? 2- les Deux photos suivantes représentent le même champ tumoral à différents grossissement : donner le score ?

- A) Je comprends.

B) Je ne comprends pas.

Q286. Cancers broncho-pulmonaires

Vous recevez une patiente de 45 ans, non tabagique, avec une tumeur sous pleurale dont la biopsie scano-guidée parle d'un Adénocarcinome moyennement différencié. Pour confirmer son origine primitive pulmonaire une étude immunohistochimique a été demandée : 1- Donnez les résultats de cette étude en cas d'origine pulmonaire de cet adénocarcinome. 2- Quelle est la mutation la plus fréquemment retrouvé dans ce cas ? 3- Expliquez en quelques mots la biopsie liquide.

A) Je comprends.

B) Je ne comprends pas.

Q287. Cancer de l'estomac

Donnez sous forme de tableau la Classification de vienne.

A) Je comprends.

B) Je ne comprends pas.

II. GRILLE DE CORRECTION

Q01: D	Q02: B	Q03: A, B, C	Q04: C	Q05: B, C
Q06: A, B, D	Q07: A, B, C	Q08: C, D	Q09: A, B	Q10: A, D
Q11: A, B, D	Q12: B, C, E	Q13: A, B, C, E	Q14: A, B, C, E	Q15: A, D, E
Q16: B, D, E	Q17: A, B, C, E	Q18: A, C, D, E	Q19: A, C, D, E	Q20: A, C, D, E
Q21: B, C, D	Q22: B, C, E	Q23: B, D, E	Q24: A, C, E	Q25: B, C, D, E
Q26: A, C	Q27: B, C, D	Q28: A, B, D, E	Q29: A, B, E	Q30: B, C, E
Q31: A, B, E	Q32: A, B, C, E	Q33: A, C, E	Q34: A, B, D	Q35: A, C
Q36: A, B, C	Q37: A, B	Q38: C	Q39: E	Q40: A
Q41: C, E	Q42: B	Q43: A, B	Q44: A	Q45: A, E
Q46: A, E	Q47: A, B, C	Q48: A, B, D, E	Q49: A, B, C, D, E	Q50: A, C, E
Q51: B	Q52: A, B, C	Q53: B	Q54: A, B, E	Q55: A, B, C, E
Q56: A, C	Q57: A, B, D	Q58: A, C, D	Q59: A, B	Q60: A, B
Q61: A, B, C	Q62: C, D	Q63: A, B	Q64: A, B, E	Q65: A, C, D
Q66: A, B	Q67: A	Q68: A, D	Q69: A, B, D	Q70: A, B, C
Q71: C	Q72: A, B, D	Q73: A, B	Q74: B, D	Q75: A, B, D, E
Q76: B, E	Q77: A, C, D, E	Q78: B, C	Q79: B	Q80: B, C, D
Q81: A, B, D, E	Q82: B, C, E	Q83: A, E	Q84: A, B, C, E	Q85: A, C, E
Q86: A, B, D	Q87: A, B, D, E	Q88: A, C, D, E	Q89: A, B, C, E	Q90: A, B, D
Q91: A, B, C, D	Q92: A, B, D, E	Q93: B, D, E	Q94: B, C, D	Q95: A, B, D, E
Q96: A, B, C, E	Q97: A, C, D, E	Q98: A, C, D, E	Q99: A, C, D, E	Q100: A, C, E
Q101: A, B, C	Q102: A, B, C, D	Q103: A	Q104: A, B, D	Q105: A, B, C
Q106: A, B, C, D	Q107: A	Q108: A, B	Q109: A, B, C	Q110: A, B, C
Q111: A, B	Q112: B	Q113: B	Q114: A, B, C, D	Q115: A, B, C
Q116: B	Q117: A, B, C	Q118: A, B	Q119: A, D	Q120: C
Q121: B, D, E	Q122: A, C, E	Q123: B, D, E	Q124: B, E	Q125: A, B, C, D, E
Q126: C	Q127: A, B, C, E	Q128: B, C, D, E	Q129: A, C, E	Q130: A, B, C, D, E
Q131: C, D, E	Q132: A, C, D, E	Q133: A, B, C, D	Q134: A, C, E	Q135: C, D
Q136: A, B, C, D, E	Q137: A, B, C	Q138: B, C, D	Q139: A, B, C, D	Q140: A, B
Q141: B	Q142: B	Q143: A, D	Q144: C	Q145: B
Q146: A, C, E	Q147: B	Q148: B	Q149: E	Q150: C
Q151: D	Q152: B	Q153: C	Q154: A	Q155: B, E
Q156: B	Q157: C	Q158: C	Q159: D	Q160: A, D
Q161: A	Q162: A	Q163: A, B	Q164: A, B, C	Q165: A, B, C, D
Q166: A	Q167: A	Q168: B	Q169: A	Q170: A, B
Q171: A, B	Q172: A, B, C, D	Q173: A, B	Q174: A, B, C	Q175: A, B
Q176: A	Q177: A, B, C	Q178: A, B, C	Q179: A	Q180: A, B, C, D
Q181: B, E	Q182: A, C, D, E	Q183: A, C, E	Q184: A, C	Q185: A, B, D, E

Q186: A, B	Q187: A, B, E	Q188: A, B, C, E	Q189: B, C, D	Q190: D, E
Q191: A, B, D	Q192: B, C, E	Q193: A, C, D	Q194: A, C, E	Q195: A, B, C, D
Q196: B, C, D, E	Q197: A, D	Q198: A, D	Q199: C	Q200: A, B
Q201: B, C	Q202: A	Q203: E	Q204: C, E	Q205: C
Q206: D	Q207: A	Q208: A	Q209: C	Q210: A, B
Q211: B	Q212: B	Q213: B, E	Q214: A	Q215: A
Q216: A	Q217: A	Q218: B	Q219: A	Q220: D
Q221: A	Q222: A	Q223: A	Q224: A	Q225: A
Q226: A	Q227: A	Q228: A	Q229: A	Q230: A
Q231: A	Q232: A	Q233: A	Q234: A	Q235: A
Q236: A	Q237: B, C, D	Q238: A	Q239: A	Q240: A
Q241: A	Q242: A	Q243: A	Q244: A	Q245: A
Q246: A	Q247: A	Q248: A	Q249: A	Q250: A
Q251: A	Q252: A	Q253: A	Q254: A	Q255: A
Q256: A	Q257: A	Q258: A	Q259: A	Q260: A
Q261: A	Q262: A	Q263: A	Q264: A	Q265: A
Q266: A	Q267: A	Q268: A	Q269: A	Q270: A
Q271: A	Q272: A	Q273: A	Q274: A	Q275: A
Q276: A	Q277: A	Q278: A	Q279: A	Q280: A
Q281: A	Q282: A	Q283: A	Q284: A	Q285: A
Q286: A	Q287: A			